

Buku Ajar

KEPERAWATAN KESEHATAN REPRODUKSI

Suryani Hartati
Muannsih
Sefrina Rukmawati
Yunida Turisna Octavia



BUKU AJAR

KEPERAWATAN KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Muanningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Sefrina Rukmawati, S.Kep., M.Kes.

Ns. Yunida Turisna Octavia , SKM., S.Kep., M.KM.



BUKU AJAR KEPERAWATAN KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis: Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Muanningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Sefrina Rukmawati, S.Kep., M.Kes.

Ns. Yunida Turisna Octavia, SKM., S.Kep., M.KM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-96029-1-4

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul "Keperawatan Kesehatan Reproduksi" ini dengan lancar dan tepat waktu. Buku ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, serta praktisi di bidang kesehatan yang berminat memperdalam wawasan mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip, serta penerapan praktis dalam lingkup kesehatan reproduksi.

Bidang kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan individu secara fisik dan emosional, namun juga menentukan kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat pentingnya aspek ini, perawat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan keperawatan yang profesional, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah terkini. Dalam praktiknya, peran perawat meliputi berbagai aspek seperti promosi kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, manajemen asuhan selama masa reproduktif, intervensi terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi, serta rehabilitasi dan edukasi bagi individu maupun komunitas yang membutuhkan.

Buku ajar ini disusun secara sistematis dan mendalam, dengan menitikberatkan pada perkembangan ilmu terkini dalam bidang kesehatan reproduksi, serta mengintegrasikan pendekatan holistik yang diperlukan dalam praktik keperawatan modern. Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, materi pembahasan yang terstruktur, ilustrasi atau diagram penjelas, studi kasus aktual, serta evaluasi pembelajaran untuk menguji pemahaman para pembaca secara optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan, masukan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk ide, saran, serta kritik konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Dengan rendah hati, kami mengakui bahwa buku ini mungkin masih terdapat berbagai kekurangan atau keterbatasan dalam penyajian materi. Oleh karena itu, kami selalu membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi peningkatan kualitas buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ajar "Keperawatan Kesehatan Reproduksi" ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan, serta mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, tenaga kesehatan, dan seluruh pembaca dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Penulis

Mei, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI.....	1
A. Pengkajian.....	4
B. Diagnosa Keperawatan	6
C. Intervensi Keperawatan.....	7
D. Implementasi Keperawatan.....	10
E. Evaluasi Keperawatan	10
F. Latihan Soal	11
G. Rangkuman Materi	13
H. Glosarium.....	14
I. Daftar Pustaka.....	15
BAB 2 PENGKAJIAN DAN PROMOSI KESEHATAN WANITA.....	17
A. Sistem Reproduksi Wanita.....	18
B. Alasan Kunjungan Ke Sistem Pelayanan Kesehatan.....	21
C. Hambatan Dalam Mencari Pelayanan Kesehatan	22
D. Resiko Kesehatan Pada Masa Kehamilan Dan Kelahiran.....	22
E. Pengkajian Kesehatan.....	24
F. Panduan Antisipasi Untuk Promosi Kesehatan Dan Pencegahan.....	28
G. Latihan Soal	30
H. Rangkuman.....	32
I. Glossarium.....	32
J. Daftar Pustaka.....	33
BAB 3 MANAJEMEN KASUS PADA SISTEM REPRODUKSI (KLASIFIKASI KASUS SISTEM REPRODUKSI DAN PRIORITAS MASALAH SISTEM REPRODUKSI)	35
A. Konsep Dasar Vaginitis	38
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	43
C. Latihan Soal	49
D. Rangkuman Materi	51
E. Glosarium.....	54

F. Daftar Pustaka.....	54
BAB 4 TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN MATERNITAS TERKAIT	
MASALAH KESEHATAN WANITA.....	57
A. Trend dan Issue Keperawatan Maternitas.....	60
B. Anemia.....	60
C. Anemia pada ibu hamil.....	65
D. Kekurangan Energi kronik (KEK).....	72
E. Abortus.....	75
F. Latihan Soal	77
G. Rangkuman Materi	79
H. Glosarium.....	80
I. Daftar Pustaka.....	82
PROFIL PENULIS	87

BAB 1

ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistim reproduksi
- Menjelaskan konsep pengkajian pada gangguan sistim reproduksi
- Menjelaskan konsep diagnose keperawatan pada gangguan sistim reproduksi
- Menjelaskan konsep intervensi pada gangguan sistim reproduksi
- Menjelaskan konsep implentasi pada gangguan sistim reproduksi
- Menjelaskan konsep evaluasi pada gangguan sistim reproduksi

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistim reproduksi
- Mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian pada gangguan sistim reproduksi
- Mahasiswa mampu mengerjakan asuhan keperawatan terdiri dari diagnose keperawatan pada gangguan sistim reproduksi
- Mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan terdiri dari intervensi pada gangguan sistim reproduksi
- Mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan terdiri dari implementasi pada gangguan sistim reproduksi
- Mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan terdiri dari evaluasi pada gangguan sistim reproduksi

Pendahuluan

Perawat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada wanita. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia RISKESDA (Kesehatan, n.d.) di tahun 2018, mengemukakan persentase gangguan reproduksi di Indonesia dalam periode 3 tahun sebanyak 2,4% dari total angka fertilitas jumlah (TFR) pada wanita usia produktif di rentang usia 15 - 49 tahun (Kemenkes, 2018). Perawat perlu membantu pasien dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya.

Bab ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system reproduksi. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system reproduksi. Metode pembelajaran buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam membuat asuhan keperawatan pada wanita yang mengalami gangguan system reproduksi. Pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif, melalui studi kasus dan pembelajaran kolaboratif sesama teman tenaga kesehatan lainnya.

Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi Diploma Tiga Keperawatan. Gambaran pembahasan pada Bab ini dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system reproduksi berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
- Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
- Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan.
- Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi, dan hasil dalam catatan keperawatan secara akurat dan sistematis.

Capaian Pembelajaran:**Kognitif:**

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan asuhan keperawatan gangguan system reproduksi pada wanita.
- Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis.

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat, seperti penanganan nyeri akibat yang timbulkan dari masalah kesehatan reproduksi pada wanita.

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini tentang asuhan keperawatan terdiri dari, pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi pada gangguan system reproduksi pada wanita.

Asuhan keperawatan menurut Nanda (Nanda, 2021):

A. Pengkajian

Tahap awal dari proses keperawatan yang sistematis adalah pengkajian, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan menentukan kondisi kesehatan pasien.

Pengkajian terdiri dari:

1. Identitas klien

Meliputi nama, usia, agama, suku/bangsa, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat dan lain lain.

2. Keluhan utama

Keluhan utama pada klien dengan gangguan system reproduksi ialah keluhan yang dirasakan akibat adanya masalah pada organ reproduksi tergantung lokasi dan jenisnya, umumnya klien mengeluh perut terasa keras, nyeri dan perdarahan pervaginam.

3. Riwayat penyakit sekarang

Klien mengeluh perdarahan pervaginam disertai nyeri pada abdomen.

4. Riwayat penyakit dahulu

yang perlu dikaji riwayat kesehatan dahulu apakah klien pernah mengalami penyakit ini sebelumnya.

5. Riwayat penyakit keluarga

Dikaji dalam keluarga apakah keluarga klien mempunyai penyakit keturunan seperti seperti cancer, mioma, kista dan penyakit dengan masalah kesehatan reproduksi.

6. Riwayat obstetric

a. Keadaan haid: dikaji tentang riwayat *menarche* dan apakah mengalami menorrhagia dan ada gangguan selama menstruasi

b. Riwayat kehamilan dan persalinan.

7. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Respirasi

Respirasi bisa meningkat atau menurun karena timbulnya nyeri.

b. Nutrisi

Klien dengan gangguan system reproduksi bisa mengalami gangguan atau tidaknya gangguan dalam nutrisi.

c. Eliminasi

Klien dengan gangguan system reproduksi bisa mengalami perubahan dalam buang air kecil : Nyeri saat berkemih, hamaturi, dan sering berkemih dan bisa juga tidak ada keluhan dalam berkemih. Klien juga bisa mengalami perubahan dalam defekasi.

d. Istirahat/tidur

Klien dengan gangguan system reproduksi, biasanya mengalami gangguan istirahat tidur karena rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh klien.

e. Personal *hygiene*

Kebutuhan personal *hygiene* pada klien dengan post operasi biasanya dibantu oleh keluarga.

f. Aktivitas

Pada klien dengan gangguan system reproduksi biasanya aktivitasnya terganggu, pekerjaan/kegiatan tidak mampu dilakukan secara maksimal karena keadaan yang masih lemah.

g. Spiritual

Klien dengan gangguan system reproduksi bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang miliki.

h. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum

Klien dengan gangguan system reproduksi biasanya tampak lemah karena adanya perdarahan dan meringis saat merasakan nyeri, kaji skala nyeri dengan rentang 1-10 menggunakan VAS.

2) Kesadaran

Kesadaran klien umumnya composmentis (CM).

3) Tanda-tanda vital

Suhu: normal/ meningkat ($N=36,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$)

Nadi: meningkat/menurun ($N=<90\text{x/menit/ } >100\text{x/menit}$)

Pernapasan: normal/meningkat ($N=18-20\text{x/menit}$)

Tekanan darah: normal/meningkat ($N=120/80\text{ mmHg}$)

4) Pemeriksaan *head to toe*

a) Sistem penglihatan

Kaji posisi mata, pergerakan bola mata klien, konjungtiva, kornea, kelopak mata, sklera.

b) Sistem pendengaran

- Kaji keadaan pendengaran, keluhan dan alat bantu dengar.
- c) System wicara
Kaji apakah ada kesulitan klien dalam berbicara.
- d) System pernapasan
Kaji apakah ada sumbatan jalan nafas, suara nafas batuk, sesak dan apakah menggunakan alat bantu nafas.
- e) System kardiovaskuler
Kaji irama jantung denyut, tekanan darah, Sirkulasi jantung, kelainan bunyi jantung,
- f) Sistem pencernaan
Kaji eliminasi fekal klien.
- g) System syaraf pusat
Kesadaran klien composmentis (CM).
- h) System perkemihan
Kaji pola berkemih klien.
- i) System integument
Kaji turgor kulit ,warna kulit dan keadaan kulit.
- j) System musculoskeletal
Kaji apakah ada kelemahan dalam bergerak
- k) Pemeriksaan payudara dan axila
Kaji bentuk buah dada, massa, lesi, tanda-tanda peradangan.
- l) Pemeriksaan abdomen
Kaji abdomen klien, teraba massa atau tidak
- m)Pemeriksaan genetalia eksterna dan inguinal
- Vulva kaji keadaan vulva klien area labia mayora dan minora.
 - Inguinal
Kaji apakah ada pembesaran kelenjar, serta apakah ada nyeri.

B. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual, potensial, atau resiko. Diagnosis keperawatan didefinisikan sebagai pernyataan yang jelas, singkat, dan pasti tentang masalah klien yang sebenarnya serta penyebabnya yang dapat dipecahkan atau diubah melalui tindakan keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI., 2017).

Berikut adalah diagnosis keperawatan yang dapat terjadi pada pasien dengan gangguan system reproduksi, diantaranya:

1. Nyeri akut b.d trauma jaringan dan reflex spasme otot sekunder akibat tumor, nekrosis dan peradangan (D.0077)
2. Hipovolemia b.d. perdarahan pervaginam berlebihan (D. 0023)
3. Resiko Infeksi b.d Insisi luka operasi (D.0142)
4. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi (D.0111)

C. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai (outcome) yang di harapkan. Tindakan keperawatan merupakan perilaku atau aktivitas spesifik yang di kerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI., 2018).

Berikut intervensi yang dapat dilakukan sesuai standar intervensi keperawatan Indonesia:

1. Nyeri Akut b.d agen pencedera fisik (D.0077)

- a. Tujuan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 x 24 jam diharapkan Tingkat Nyeri menurun (L.08066).
- b. Kriteria Hasil:
 - 1) Keluhan nyeri menurun
 - 2) Tidak tampak meringis
 - 3) Sikap protektif menurun
 - 4) Tidak tampak gelisah
 - 5) Keluhan kesulitan tidur menurun
 - 6) Frekuensi nadi membaik
- c. Intervensi: Menejemen Nyeri (L.08238)
 - 1) Observasi
 - a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri.
 - b) Identifikasi skala nyeri.
 - c) Identifikasi respons nyeri nonverbal.
 - 2) Terapeutik
 - a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti *slow deep breathing* dan relaksasi benson karena menurut penelitian (Rustini et al., 2022) terbukti efektif untuk mengurangi rasa nyeri.
 - b) kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan).
 - c) fasilitasi istirahat dan tidur.

- 3) Edukasi
 - a) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.
- 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.

2. Hipovolemia b.d. perdarahan pervaginam berlebihan (D. 0023)

- a. Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 x 24 jam di harapkan status cairan membaik (L.03028)
- b. Kriteria Hasil
 - 1) Turgor kulit membaik
 - 2) Membran mukosa membaik
 - 3) Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - 4) pendarahan berhenti, keluaran urine 1cc/Kg BB/Jam
- c. Intervensi Keperawatan : Manajemen Hipovolemia
 - 1) Observasi
 - a) Periksa tanda dan gejala hypovolemia (mis. frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa, kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah)
 - b) Monitor intake dan output cairan
 - 2) Terapeutik
 - a) Hitung kebutuhan cairan
 - b) Berikan posisi *modified trendelenburg*
 - c) Berikan asupan cairan oral
 - 3) Edukasi
 - a) Anjurkan memperbanyak asupan oral
 - b) Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak
 - 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis (mis. NaCl, RL)
 - b) Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis (mis. glukosa 2,5%, NaCl 0,4%)
 - c) Kolaborasi pemberian cairan koloid (mis. albumin, plasmanate)
 - d) Kolaborasi pemberian produk darah

3. Resiko Infeksi b.d Insisi luka operasi

- a. Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 x 24 Jam di harapkan tingkat infeksi menurun (L.14137)
- b. Kriteria Hasil
 - 1) Tidak ada tanda-tanda infeksi (demam,nyeri,kemerahan,dan bengkak)

- 2) kadar sel darah putih membaik
- c. Intervensi: Pencegahan Infeksi
 - 1) Observasi
 - a) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan siskemik
 - 2) Terapeutik
 - a) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien.
 - b) Pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi
 - 3) Edukasi
 - a) jelaskan tanda dan gejala infeksi
 - b) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar
 - c) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka post operasi
 - d) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi agar mempercepat penyembuhan menurut penelitian (Sebayang & Ritonga, 2021)
 - 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi pemberian imunisasi (antibiotik) , jika perlu.

4. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi (D.0111)

- a. Tujuan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 x 24 Jam diharapkan tingkat pengetahuan membaik (L.12111).
- b. Kriteria Hasil:
 - 1) Perilaku sesuai anjuran meningkat.
 - 2) Verbalisasi minat dalam belajar meningkat.
 - 3) Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat.
 - 4) Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat.
 - 5) Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun.
 - 6) Persepsi yang keliru terhadap masalah menurun.
- c. Intervensi: Edukasi Kesehatan (L.12383)
 - 1) Observasi
 - a) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi
 - 2) Terapeutik
 - a) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
 - b) jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, agar menurut siapa
 - c) Berikan Kesempatan untuk bertanya.
 - 3) Edukasi
 - a) Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan.

- b) Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

D. Implementasi Keperawatan

Dokumentasi implementasi keperawatan mencakup catatan tentang tindakan yang diberikan kepada klien. Pencatatan ini mencakup tindakan yang diberikan kepada klien baik secara mandiri maupun kolaboratif, serta pemenuhan kriteria hasil terhadap tindakan yang diberikan kepada klien (Supardi, 2013). Teknik relaksasi adalah metode penanganan nyeri non-farmakologi yang dapat memperlancar sirkulasi darah, yang meningkatkan suplai oksigen dan dapat mengurangi tingkat nyeri dan mempercepat penyembuhan luka pasien setelah operasi. Widianty, 2020 Teknik farmakologis dan nonfarmakologis dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pasca bedah. Teknik nonfarmakologis yang dikenal sebagai teknik relaksasi nafas dalam dapat digunakan untuk mengurangi nyeri yang muncul setelah operasi di Rumah Sakit. Teknik ini mencakup latihan nafas dalam.

E. Evaluasi Keperawatan

Tujuan evaluasi adalah untuk membuat keputusan tentang seberapa efektif asuhan keperawatan antara tujuan keperawatan pasien yang telah ditetapkan dan respons perilaku pasien. Tujuan evaluasi antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana kesehatan pasien berkembang, untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan produktif tindakan keperawatan yang telah diberikan, untuk menilai pelaksanaan asuhan keperawatan, untuk mendapatkan umpan balik, dan untuk menentukan apakah pasien bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.(Apriyani & Suarni, 2019).

Penentuan masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi adalah dengan cara membandingkan antara SOAP dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Subjektif adalah informasi berupa ungkapan yang didapat dari pasien setelah tindakan diberikan. Objektif adalah informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan dilakukan. Analisis adalah membandingkan antara informasi subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi. *Planning* adalah rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa(Apriyani & Suarni, 2019) :

1. S: subjektif, yaitu data subyektif yang didapat dari keluhan klien, dalam pengambilan kasus saat pengkajian dengan metode wawancara langsung kepada klien mengatakan nyeri pada area organ reproduksi yang bermasalah.
2. O: objektif, yaitu data objektif yang didapatkan dari hasil pengamatan pada saat perawatan, dalam pengambilan kasus pada saat pengkajian dengan cara mengobservasi keadaan klien didapatkan hasil klien tampak meringis kesakitan.
3. A: analisis/assessment, yaitu masalah dan diagnosis keperawatan yang dianalisa dari data subjektif dan data objektif,
4. P: perencanaan *planning*, yaitu merencanakan kembali pengembangan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, baik yang sekarang maupun yang akan datang
5. Langkah terakhir dalam urutan prosedur keperawatan adalah evaluasi keperawatan, penilaian perawat sangat membantu untuk menentukan apakah tujuan kegiatan keperawatan yang ditawarkan kepada pasien telah terpenuhi sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan atau memerlukan strategi yang berbeda. Selain perubahan fungsi dan tanda dan gejala spesifik, evaluasi keperawatan juga mempertimbangkan kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotorik pasien. (Apriyani & Suarni, 2019).

F. Latihan Soal

Latihan dibuat dalam bentuk

1. Seorang perempuan, umur 25 tahun, dirawat di RS, diagnosis Kista Ovarium, sudah dirawat selama 3 hari. Hasil pengkajian : mengeluh nyeri saat berkemih dengan skala 5, saat dipalpasi didapatkan adanya benjolan di atas kandung kemih. Pemeriksaan diagnostic USG didapatkan adanya letak batas tumor di ovarium kanan sebesar 10 cm. Apakah pengakajian selanjutnya pada kasus tersebut?
 - A. Tanda tanda vital
 - B. Adakah mual muntah
 - C. Adakah hematuri saat BAK
 - D. Perdarahan pervaginam
 - E. Adakah penyakit keturunan
2. Seorang perempuan, umur 28 tahun dirawat di rumah sakit, diagnosis Kista Ovarium. Pasien mengeluh nyeri pada perut bagian bawah seperti melilit – lilit dan panas pada bokong secara terus menerus, skala nyeri 5 . Hasil pemeriksaan fisik TD 100/60 mmHg, frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi pernafasan 19 x/menit, Suhu 36,5°C, bentuk abdomen asimetris, terdapat benjolan di abdomen dekstra, terdapat perdarahan pervaginam 20 CC. Apakah diagnosis prioritas pada kasus tersebut?

- A. Gangguan eliminasi urine b.d adanya benjolan pada abdomen
 - B. Hipovolemia b.d. perdarahan pervaginam berlebihan
 - C. Resiko Infeksi b.d Insisi luka operasi
 - D. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi
 - E. Nyeri akut b.d trauma jaringan dan reflex spasme otot sekunder akibat tumor, nekrosis dan peradangan
3. Seorang perempuan, umur 37 tahun dirawat dengan Ca Serviks stadium 3A, terdiagnosa sejak 10 bulan yang lalu, klien mengatakan nyeri perut sampai ke pinggang. Pemeriksaan fisik : TD 130/90 mmHg, nadi 104x/mnt, Suhu 36°C, frekuensi nafas 18x/mnt. Apakah tindakan keperawatan yang harus segera dilakukan?
- A. Identifikasi skala nyeri.
 - B. Berikan kompres dingin
 - C. Identifikasi respons nyeri secara verbal.
 - D. Alihkan nyeri dengan teknik distraksi
 - E. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri.
4. Seorang perempuan, umur 28 tahun dirawat di rumah sakit, diagnosis Kista Ovarium. Pasien mengeluh nyeri pada perut bagian bawah seperti melilit – lilit dan panas pada bokong secara terus menerus. Hasil pemeriksaan fisik TD 100/60 mmHg, frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi pernafasan 19 x/menit, Suhu 36,5oC, bentuk abdomen asimetris, terdapat benjolan di abdomen dekstra, terdapat perdarahan pervaginam 20 CC. Apakah tindakan terapeutik yang harus dilakukan pada kasus tersebut ?
- A. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
 - B. Fasilitasi istirahat dan kenyamanan pasien
 - C. Monitor tanda tanda vital terutama nadi pasien
 - D. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti *slow deep breathing* dan relaksasi benson
 - E. kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan).
5. Seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat dengan Ca Serviks stadium 3A, terdiagnosa sejak 10 bulan yang lalu, klien mengatakan nyeri perut skala 6. Pemeriksaan fisik: TD 130/90 mmHg, frekuensi nadi 104x/mnt, Suhu 36°C, frekuensi nafas 18x/mnt. Apakah evaluasi keperawatan yang harus segera dilakukan?

- A. Skala nyeri 1-3
- B. Pasien tampak tenang
- C. Perdarahan berkurang
- D. Tanda tanda vital dalam batas normal
- E. Pasien tampak rileks dan nyaman

Essay 5 Soal

1. Pada kasus ibu dengan masalah kesehatan reproduksi. Sebutkan 3 prioritas utama yang harus dikaji oleh seorang perawat ?
2. Pada kasus ibu dengan masalah kesehatan reproduksi. Sebutkan prioritas diagnose keperawatan yang sering muncul ?
3. Pada kasus ibu dengan masalah kesehatan reproduksi. Apasaja tindakan utama yang harus dilakukan oleh seorang perawat ?
4. Pada kasus ibu dengan masalah kesehatan reproduksi. Sebutkan evaluasi yang diharapkan oleh seorang perawat ?
5. Pada kasus ibu dengan masalah kesehatan reproduksi , Apasaja yang harus didokumentasi didalam catatan keperawatan ?

Kunci Jawaban

- A. D
- B. E
- C. E
- D. D
- E. A

G. Rangkuman Materi

Asuhan keperawatan pada gangguan system reproduksi dimulai dari :

1. Pengakajian adalah tahap awal dari proses keperawatan yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data meliputi biopsikososial spiritual untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien terdiri dari pengkajian dasar dan pemeriksaan fisik *head to toe* , pengkajian utama meliputi adanya nyeri,perdarahan, dan massa pada area organ reproduksi yang terkena
2. Diagnosa keperawatan umumnya timbul
 - a. Nyeri akut b.d trauma jaringan dan reflex spasme otot sekunder akibat tumor, nekrosis dan peradangan.
 - b. Hipovolemia b.d. perdarahan pervaginam berlebihan.
 - c. Resiko Infeksi b.d Insisi luka operasi.
 - d. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi.
3. Intervensi, implementasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang timbul :

- a. Masalah nyeri dengan tindakan terapeutik ; Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti *slow deep breathing* dan relaksasi benson karena menurut penelitian (Rustini et al., 2022) terbukti efektif untuk mengurangi rasa nyeri nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti *slow deep breathing* dan relaksasi benson
 - b. Masalah hypovolemia: Periksa tanda dan gejala hypovolemia (mis. frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa, kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah).
 - c. Masalah infeksi : Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik
 - d. Masalah kurang pengetahuan: Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi
4. Evaluasi didefinisikan sebagai keputusan dari efektifitas asuhan keperawatan antara dasar tujuan keperawatan pasien yang telah ditetapkan dengan respon perilaku pasien yang ditampilkan yang terdiri dari :
- a. S: subjektif, didapat dari keluhan klien, dalam pengambilan kasus saat pengkajian dengan metode wawancara langsung kepada klien mengatakan nyeri pada area organ reproduksi yang bermasalah.
 - b. O: objektif, didapatkan dari hasil pengamatan pada saat perawatan, dalam pengambilan kasus pada saat pengkajian dengan cara mengobservasi keadaan klien didapatkan hasil klien tampak meringis kesakitan.
 - c. A: analisis/assessment, yaitu masalah dan diagnosis keperawatan yang dianalisa dari data subjektif dan data objektif,
 - d. P: planning, yaitu merencanakan kembali pengembangan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, baik yang sekarang maupun yang akan datang

H. Glosarium

Head to Toe: pemeriksaan yang dilakukan dimulai dari kepala sampai ujung kaki untuk menunjang hasil pengkajian.

Personal hygiene: tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. kebersihan diri pasien terkait kebersihan kulit tubuh, rambut, mulut, perinium (organ vital)

Modified trendelenburg: posisi berbaring telentang dengan kepala sejajar tubuh dan kaki diangkat secara pasif yang bertujuan untuk mengalirkan darah ke jantung.

Hipovolemia: kurangnya volume darah dalam tubuh.

Slow deep breathing: teknik relaksasi yang dilakukan dengan mengatur pernapasan secara dalam dan lambat.

I. Daftar Pustaka

- Apriyani & Suarni. (2019). *Metodelogi Keperawatan*. Pustaka Panasea.
- Kemenkes, R. . (2018). *Profil kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia health profile 2018]*.
- Kesehatan, B. P. dan P. (n.d.). *Hasil Utama RISKESDAS 2018*. Kementrian Kesehatan RI.
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf
- Nanda. (2021). *Nursing Diagnoses Definitions and Classification 2021-2023* (Twelfth). Thieme Medical Publishers, Inc.
- Rustini, N., Tridiyawati, F., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Nusantara, A. (2022). Efektifitas Relaksasi Slow Deep Breathing Dan Relaksasi Benson terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea. *Manuju: Malahayati Nursing Jurnal*, 4(3), 683–692. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33024/mnj.v4i3.6066>
- Sebayang, W. B. R., & Ritonga, F. (2021). *Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review) Effective Nutrition Accelerates Perineum Wound Healing on Mother Post Partum (Systematic Review)*. 12, 330–336.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. Dewan Pengurus PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (II (ed.); 1st ed.). DPP PPNI.

BAB 2

PENGKAJIAN DAN PROMOSI KESEHATAN WANITA

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan Sistem Reproduksi Wanita
- Menjelaskan Alasan Kunjungan Ke Sistem Pelayanan Kesehatan
- Menjelaskan Hambatan Dalam Mencari Pelayanan Kesehatan
- Menjelaskan Resiko Kesehatan Pada Masa Kehamilan Dan Kelahiran
- Menjelaskan Pengkajian Kesehatan
- Menjelaskan Panduan Antisipasi Untuk Promosi Kesehatan Dan Pencegahan

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan Sistem Reproduksi Wanita
- Mampu menjelaskan Alasan Kunjungan Ke Sistem Pelayanan Kesehatan
- Mampu menjelaskan Hambatan Dalam Mencari Pelayanan Kesehatan
- Mampu menjelaskan Resiko Kesehatan Pada Masa Kehamilan Dan Kelahiran
- Mampu menjelaskan Pengkajian Kesehatan
- Mampu menjelaskan Panduan Antisipasi Untuk Promosi Kesehatan Dan Pencegahan

Uraian Materi

A. Sistem Reproduksi Wanita

Struktur eksternal (organ genital luar) merupakan seluruh bagian dari luar daerah pubis sampai dengan perinium. organ genital luar ini meliputi mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, dan perineum. Mons pubis terletak pada bagian anterior simfisis pubis yang merupakan bantalan lemak. Labia mayor adalah bagian yang terdiri dari dua lipatan jaringan lemak, meluas ke arah bawah dan ke belakang dari mons pubis dan melindungi struktur di dalam vulva. Labia minor adalah bagian yang terdiri dari dua lipatan jaringan lemak berwarna kemerahan dan tertutup oleh labia mayor. Klitoris merupakan jaringan erektile ujung saraf sensoris.

Vestibulum vagina merupakan bagian yang tertutup oleh labia minor yang terdiri dari uretra, kelenjar skene, vagina, dan kelenjar bartolin. Kelenjar skene memproduksi mukus, terletak di sisi kanan dan kiri uretra. Liang vagina terletak di bawah vestibulum. Himen mengelilingi liang vagina dan tersusun dari jaringan ikat. Kelenjar Bartolini terletak di posterior kedua sisi liang vagina. Perinium merupakan area otot yang dibungkus kulit menyelimuti struktur panggul.

Struktur internal terdiri dari vagina, uterus, tuba uterine, dan ovarium. vagina merupakan fibromuskular yang berstruktur tubular berlipat sepanjang vulva hingga uterus dan berada diantara kandung kemih dan rektum. Uterus merupakan organ muskular yang berada di garis tengah rongga panggul antara kandung kemih dan rektum di atas vagina. Dinding uterus terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan endometrium, lapisan myometrium, dan bagian dari peritonium. Tuba uterine menempel pada fundus uterus. tuba uterine berfungsi sebagai jalur ovarium dengan uterus sebagai tempat melintasnya ovum. Ovarium berada di kedua sisi uterus. Ovarium berfungsi untuk ovulasi dan produksi estrogen, progesterone, dan androgen.

Tulang panggul terdiri dari dua tulang inominata, sacrum, koksigeal. Panggul terbagi menjadi dua bagian yaitu panggul palsu (panggul mayor) dan panggul sejati (panggul minor). Panggul mayor merupakan panggul bagian atas atau pintu masuk panggul. Panggul minor merupakan kanal tulang berbentuk melengkung dibagian bawah. Panggul minor meliputi pintu masuk panggul, rongga panggul, dan pintu keluar panggul. Fungsi tulang panggul sebagai pelindung struktur panggul, penyangga, dan mengakomodasi pertumbuhan janin selama kehamilan.

Payudara berada di antara iga kedua dan keenam yang merupakan sepasang kelenjar mammae. Setiap kelenjar mammae memiliki lobus, yang terbagi menjadi bagian lobulus. Lobulus merupakan kumpulan asinar. Asinar diselubungi oleh sel epitel yang

menyekresi kolostrum dan susu. Duktus dari lobulus akan menyatu pada putting susu (papilla mammae) yang dikelilingi oleh areola mammae. Payudara diselubungi oleh kulit yang mengandung jaringan limfatik superfisial yang luas. Jalur limfatik mengalirkan cairan limfe ke arah lateral menuju aksila.

Menstruasi adalah perdarahan uterus secara periodik setelah ovulasi. Siklus menstruasi merupakan peristiwa yang terjadi saling berhubungan di endometrium, hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi mengkondisikan uterus sebagai persiapan kehamilan. Jika tidak ada proses kehamilan, terjadi menstruasi. Siklus menstruasi berlangsung rata-rata 28 hari, durasi menstruasi rata-rata 5 hari. Siklus endometrium terbagi menjadi empat fase yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekretorik, fase iskemik.

Fase menstruasi, peluruhan dari dua per tiga lapisan endometrium. Fase proliferasi, masa pertumbuhan lapisan endometrium yang berlangsung cepat kurang lebih 7 hari ke lima sampai terjadi ovulasi. Fase sekretorik, endometrium akan dilengkapi dengan darah dan sekresi kelenjar sebagai perlindungan dan nutrisi untuk ovum yang terfertilisasi. Ovum yang terfertilisasi akan sampai kurang lebih 7 sampai 10 hari setelah ovulasi. Jika fertilisasi tersebut tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami regresi menyebabkan kadar estrogen dan progesterone terjadi penurunan dengan cepat. Sehingga arteri spiralis mengalami spasme. Fase iskemik, lapisan fungsional endometrium mengalami nekrosis akibat terhentinya suplai darah, lapisan fungsional endometrium terpisah dari lapisan basal dan terjadi menstruasi.

Respon seksual, stimulasi seksual akan menyebabkan kongesti pembuluh darah vena sehingga menimbulkan lubrikasi vagina, pembengkakan, dan distensi genital. Sekresi hormone dari ovarium, hipotalamus, dan hipofisis anterior terlibat dalam mengontrol produksi sel seks dan sekresi hormone seks steroid. Siklus respon seksual, terbagi menjadi empat fase yaitu fase eksitasi, fase plateau, fase orgasmik, dan fase resolusi.

Tabel 2.1
Fase respon seksual

REAKSI UMUM PADA KEDUA JENIS KELAMIN	REAKSI PADA WANITA	REAKSI PADA PRIA
FASE EKSITASI Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, puting susu ereksi, myotonia mulai terjadi	Diameter klitoris bertambah dan membesar, genetalia eksternal mengalami kongesti dan menjadi gelap, lubrikasi vagina terjadi, dua pertiga bagian atas vagina bertambah Panjang dan melebar, serviks dan uterus tertarik ke atas ukuran payudara meningkat	Ereksi penis mulai terjadi, penis bertambah Panjang dan membesar. kulit skrotum mengalami kongesti dan menebal, testis mulai membesar dan naik ke atas tubuh.
FASE PLATO Denyut jantung dan tekanan darah terus meningkat, pernapasan meningkat, myotonia terlihat, geraman wajah terjadi.	Kepala klitoris mengalami retraksi, sepertiga bawah vagina membesar, perubahan warna kulit terjadi, kemerahan di payudara, perut	Ujung penis sedikit membesar, skrotum terus meregang dan menebal, testis terus terangkat dan membesar, pengeluaran cairan preorgasmik dua atau tiga tetes terlihat pada ujung penis
FASE ORGASMIK Denyut jantung dan tekanan darah dan respirasi meningkat maksimal, terjadi spasme otot yang tidak disadari, sfingter anus eksternal berkonstriksi	Kontraksi ritmik kuat dirasakan pada klitoris, vagina, dan uterus, sensasi panas menyebar pada area panggul	Testis terangkat maksimal, kontraksi ritmik terjadi di penis, ejakulasi semen terjadi.
FASE RESOLUSI Denyut jantung tekanan darah, dan respirasi Kembali normal. Ereksi puting susu Kembali normal,	Pembengkakan genetalia eksternal dan vagina Kembali normal, uterus menurun pada posisi normalnya, serviks digenangi oleh cairan semen, ukuran payudara	Sebanyak 50% ereksi hilang segera setelah ejakulasi, penis perlahan-lahan Kembali ke ukuran normal, testis dan skrotum Kembali ke ukuran normal,

miotonia normal	Kembali	mengecil, kemerahan pada kulit menghilang.	
-----------------	---------	--	--

B. Alasan Kunjungan Ke Sistem Pelayanan Kesehatan

Promosi Kesehatan prakonsepsi, wanita dan pasangannya akan mendapatkan informasi terkait cara mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, penanganan resiko stress, dan perilaku sehat yang akan membantu wanita dan calon janinnya sejahtera. Skrining kesehatan prakonsepsi merupakan bagian dari pelayanan rutin wanita usia reproduktif yang harus diberikan oleh petugas kesehatan. Promosi Kesehatan wanita sebaiknya dimulai sebelum pembentukan organ penting janin yaitu antara 17 dan 56 hari setelah konsepsi. Wanita biasanya tidak menyadari bahwa dirinya hamil dan tidak melakukan kunjungan prenatal. Pertumbuhan janin pada trimester pertama paling rentan dapat terpajan oleh berbagai macam bahaya lingkungan intrauterus.

Asuhan prakonsepsi sangat penting bagi wanita terutama yang memiliki riwayat masalah pada kehamilan sebelumnya. Hal ini dapat mencegah kejadian berulang pada kehamilan berikutnya. Wanita dapat terpajan dengan bahanteragenik seperti obat-obatan, bahan kimia, atau bahkan memiliki kelainan genetik. Konseling prakonsepsi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait efek dari bahan-bahan dan penyakit lainnya, wanita mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan terbaik bagi kehamilannya. Pelayanan prakonsepsi pada wanita usia resproduktif adalah dari menarch (pertama kali menstruasi) sampai dengan menopause pada setiap kunjungan, tidak terbatas hanya untuk wanita hamil dan Kesehatan wanita.

Promosi Kesehatan umum yang dapat diberikan antara pain nutrisi, olahraga dan istirahat, menghindari kecanduan substansi (rokok, alcohol, obat-obat rekreasional. Penting juga dilakukan pengkajian resiko seperti Riwayat penyakit kronis, penyakit infeksius, Riwayat reproduksi, kelainan genetik, medikadi dan pengobatan medis, tingkah laku personal (merokok, obesitas, kekerasan dalam rumah tangga, kesiapan kehamilan, kondisi lingkungan, ancaman keselamatan, bahan kimia, radiasi.

Pendekatan holistik terhadap pelayanan kesehatan wanita meliputi kebutuhan kesehatan wanita seumur hidupnya, Wanita melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan karena menginginkan kehamilan. Infertilitas dapat menyebabkan gangguan emosional, perasaan gagal dan stres bagi Sebagian pasangan suami istri. Selain itu, masalah msntruasi juga terjadi pada wanita yang mengharuskan wanita datang ke pelayanan kesehatan. kelainan menstruasi yang sering terjadi diantaranya

amenorea, dismemorea, sindrom premenstrual, endometriosis, menoragia, dan metroragia. kunjungan ke pelayanan Kesehatan juga banyak dilakukan oleh wanita yang mengalami perimenopause, dikarenakan perdarahan tidak teratur, perasaan panas dan kemerahan, Wanita membutuhkan informasi yang benar terhadap mitos-mitos yang kurang tepat, pemeriksaan secara menyeluruh.

C. Hambatan Dalam Mencari Pelayanan Kesehatan

Masalah finansial, keuangan yang terbatas dan kesadaran yang kurang menyebabkan kurangnya akses ke pelayanan Kesehatan, penundaan mencari pelayanan Kesehatan, Tindakan pencegahan yang kurang, sedikit informasi yang akurat terkait Kesehatan dan pelayanan kesehatan. Isu kebudayaan, Petugas kesehatan dituntut harus dapat mempertimbangkan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi pengobatan. Isu gender, jenis kelamin petugas kesehatan peranan khususnya di pelayanan pemeriksaan pap smear, pemeriksaan kehamilannya, dan pertolongan persalinan.

D. Resiko Kesehatan Pada Masa Kehamilan Dan Kelahiran

Kehamilan pada remaja, berusia 16 tahun atau kurang memberikan stress baru bagi perkembangannya. Remaja umumnya belum memiliki sumber finansial yang dapat mendukung kehamilannya dan belum matang dalam menjalankan pelayanan prenatal. Faktor sosial dan budaya, wanita dan keluarganya mungkin memiliki nilai-nilai hidup, sosial, dan pandangan terhadap kesehatan atau penyakit yang mengajarkan praktik-praktik berbeda misalnya mengharamkan makanan, metode kebersihan, pengaruh dari cuaca, tingkah laku dalam mencari pelayanan kesehatan. Keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup dapat menimbulkan stress dan konflik, resiko yang lebih tinggi untuk gangguan psikologis.

Penggunaan dan penyalahgunaan zat, zat legal (rokok, kafein, alkohol) dapat menyebabkan ketergantungan atau bahaya bagi kehamilan. Kurang nutrisi dan obesitas, dapat menimbulkan masalah yang lebih serius seperti penyakit jantung, tumor ganas, penyakit serebrovaskuler, dan diabetes. Diet ekstrem juga dapat menimbulkan resiko seperti kurangnya jumlah kalsium dapat memicu osteoporosis. Masalah kandungan, dapat memberikan efek buruk bagi kehamilan seperti infertilitas, keguguran, persalinan premature, masalah pada janin dan neonates. Kanker kandungan dan lainnya juga dapat mempengaruhi kesehatan wanita.

Tabel 2.2
Kanker pada kandungan dan lainnya

KANKER	FAKTOR RESIKO	TANDA DAN GEJALA
Serviks	Infeksi HVP merupakan penyebab tersering, faktor resiko lainnya meliputi hubungan seksual pada usia dini, merokok, infeksi HIV, infeksi menular seksual, banyak pasangan seksual	Flek-flek abnormalitas atau perdarahan vagina adalah tanda awal
Endometrium	Pajanan terkait estrogen seperti nullparitas, terapi estrogen yang tidak dilawan, infertilitas, menarche dini, menopause telat, obesitas, hipertensi, diabetes, dan Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara atau ovarium.	Perdarahan abnormal uterus merupakan tanda utama
Ovarium	Faktor resiko meliputi Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara atau ovarium dan tidak memiliki anak pada usia yang lebih tua resiko meningkat dengan usia	Pembesaran abdomen disertai dengan gejala saluran cerna yang tidak jelas dan persisten merupakan tanda yang paling sering
Vulva, vagina tuba uterina	Kanker vulva dan vaginadihubungkan dengan HPV virus herpes simpleks,	Lesi sering kali merupakan tanda pertama kanker vulva. wanita dengan kanker vagina atau tuba uterine dapat tanpa gejala atau mengalami perdarahan vagina
Paru-paru	Merokok merupakan faktor resiko yang paling penting. resiko lainnya meliputi pajanan terhadap bahan-bahan industry tertentu, kimia organik seperti asbes, dan radiasi	Batuk perssiten, dahak bercampur darah, nyeri dada, dan penurunan atau bronchitis berulang
Payudara	Riwayat keluarga, mutase genetic yang diturunkan menarche dini, monopouse terlambat, nullparitas atau memiliki anak pada usia yang lebih tua, kemungkinan penggunaan estrogen pasca	Tanda paling dini adalah terdapatnya abnormalitas, yang ditemukan dalam mammogram sebelum dapat dideteksi oleh wanita atau klinis.

	menopause, resiko meningkat sering dengan usia	
Kolon	Riwayat personal atau keluarga dengan kanker atau polips kolorektal, penyakit inflamasi usus, dan diet tinggi lemak rendah serat, resiko meningkat sering dengan usia	Tanda meliputi perdarahan rectum, darah dalam tinja, dan perubahan kebiasaan buang air besar

Kekerasan pada wanita antara lain pembatasan ekonomi, kekerasan seksual, intimidasi, isolasi, korban terror, dan anak mereka. kehamilan paling sering merupakan waktu dimulainya atau meningkatnya kekerasan. Wanita yang mengalami kekerasan sering mempercayai bahwa diri mereka sendiri yang salah karena tidak menjadi istri yang baik dan kurang percaya diri. Isolasi sosial merupakan bentuk lain dari kekerasan terhadap wanita yang biasanya disebabkan oleh stigma, ketakutan, pembatasan oleh pasangannya.

E. Pengkajian Kesehatan

Anamnesis, Perawat memastikan usia, status pernikahan, ras, etnis, alamat, nomor telfn, pekerjaan, dan tanggal kunjungan. Anamnesis harus dilakukan dalam situasi yang pribadi, nyaman, rileks, dan tidak tergesa-gesa. Perawat memperkenalkan diri, memberikan pertanyaan dengan tidak menuduh. Perawat harus mengenali kelemahan dan menjaga kerahasiaan, memperhatikan latar belakang budaya, Perawat harus dapat meyakinkan bahwa setiap pertanyaan saling berhubungan. Anamnesis dimulai dengan pertanyaan terbuka.

Wanita dengan kelainan fisik dan mental harus dihormati dan dilibatkan dalam pengkajian dan pemeriksaan fisik. Pengkajian dan pemerikaan fisik dapat disesuaikan dengan kebutuhan wanita. Wanita dengan kebutuhan khusus ini sama seperti pasien lainnya, mereka membutuhkan penjelasan yang lengkap mengenai tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan. Dukungan dari perawat dapat membantu wanita menjadi rileks dan pemeriksaan berjalan dengan baik. Perawat mengkaji Riwayat kesehatan selama dilakukan anamnesis seperti data biografi, alasan datang atau berkunjung ke pelayanan kesehatan, kesehatan saat ini atau Riwayat penyakit sekarang, Riwayat penyakit terdahulu, Riwayat keluarga, pemeriksaan berdasarkan sistem, pengkajian fungsi (aktifitas atau kebiasaan hidup sehari-hari).

Pemeriksaan fisik, pengkajian umum terkait status kesehatan secara keseluruhan sebelum memulai pemeriksaan, data objektif dicatat berdasarkan sistem atau lokasi. Rincikan hasil pemeriksaan meliputi:

1. **Penampilan umum:** Usia, ras, seks, status kesehatan, postur, tinggi, berat badan, perkembangan, pakaian, hygiene, afek, kesadaran, orientasi, kooperatif atau tidak, kemampuan berkomunikasi.
2. **Tanda vital:** temperatur, nadi, respirasi, tekanan darah
3. **Kulit:** warna, integritas, tekstur, hidrasi, temperature, edema, keringat berlebih, bau yang tidak biasa, adanya lesi, tekstur rambut, bentuk kuku, warna, tekstur.
4. **Kepala:** ukuran, bentuk, trauma, massa, jaringan parut, bercak kemerahan atau kebotakan, kesimetrisan wajah, adanya edema.
5. **Mata:** ukuran pupil, bentuk, reaktivitas, inspeksi konjungtiva, sklera ikterik, pupil edema, pendarahan, kelopak mata, Gerakan bola mata, lapang pandang dan kejelasan penglihatan.
6. **Telinga:** bentuk dan kesimetrisan, rasa nyeri, adanya cairan yang keluar, kanal eksternal, dan membrane timpani, pendengaran.
7. **Hidung:** kesimetrisan, nyeri, adanya cairan yang keluar, mukosa, peradangan, nyeri sinus frontal, atau maksila, deskriminasi bau-bauan.
8. **Mulut dan tenggorok:** hygiene, kondisi gigi, pemakaian gigi palsu, bentuk bibir, lidah, mukosa pipi dan mulut, eritema, edema, eksudat, pembesaran tonsil, palatum, uvula, refleks dan ulkus.
9. **Leher:** mobilitas, massa, rentang pergerakan, deviasi trakea, ukuran tiroid, bruit karotis.
10. **Kelenjar limfe:** leher, intraklavikula, aksila, troklear, adenopati inguinal, ukuran, bentuk, rasa nyeri, dan konsistensi
11. **Payudara:** perubahan kulit, cekungan, kesimetrisan, parut, rasa nyeri, cairan yang keluar, massa, karakteristik puting susu dan areola.
12. **Jantung:** denyut jantung, ritme, murmur, gesekan, gallop, klik, heaves, atau Gerakan precordial
13. **Vaskular perifer:** distensi vena jugularis, bruit, edema, pembengkakan, distensi vena, tanda homans atau nyeri pada ekstremitas.
14. **Paru-paru:** kesimetrisan dada saat respirasi, mengi, crackles, ronki, fremitus vocal, whispered pectoriloquy (adanya pengerasan suara bisikan saat auskultasi punggung pasien), perkusi, dan pergerakan diafragma, suara napas sama dan bersih pada kedua lapang paru.
15. **Abdomen:** bentuk, parut, bising usus, konsistensi, rasa nyeri, supel, massa, organomegaly, pembesaran hati, perkusi, nyeri ketok kostovertebra.
16. **Ekstremitas:** edema, ulserasi, rasa nyeri, varises, eritema, tremor, deformitas.

- 17. Genetlia dan saluran kemih:** genetalia eksternal, perinium, mukosa vagina, serviks, peradangan, rasa nyeri, keluarnya cairan, perdarahan, ulkus nodul, massa, bagian internal vagina, palpasi bimanual, rektrovagina pada serviks, uterus, dan adneksa.
- 18. Rektum:** tonus sfingter, massa, hemoroid, kontur dinding rectum, rasa nyeri, dan tinja untuk perdarahan tidak terlihat.
- 19. Muskuloskeletal:** postur, kesimetrisan massa otot, atrofi otot, kelemahan, bentuk sendi, rasa nyeri atau krepitus, Gerakan sendi, instabilitas, kemerahan, pembengkakan, atau deviasi tulang belakang.
- 20. Neurologi:** status mental, orientasi, memori, mood, kejelasan bicara dan pemahaman, densasi, kekuatan, refleks tendon dalam dan superfisial, gaya berjalan, keseimbangan, serta koordinasi dengan pergerakan cepat.

Pemeriksaan panggul:

1. Cuci tangan
2. Susun peralatan
3. Minta wanita untuk mengosongkan kandung kemihnya sebelum pemeriksaan (dapatkan specimen urine bersih jika diperlukan)
4. Bantu dengan Teknik relaksasi. Minta wanita meletakkan tangannya di atas dada kurang lebih di bawah diafragma, dan minta untuk bernapas dalam dan lambat.
5. Dukung wanita untuk terlibat dalam pemeriksaan jika ia menginginkannya.
6. Kaji dan tangani tanda-tanda apabila ada masalah seperti hipotensi pada posisi terlentang
7. Hangatkan speculum dalam air hangat jika speculum yang sudah dihangatkan sebelumnya tidak tersedia
8. Gunakan sarung tangan dan bantu pemeriksa dalam mengumpulkan specimen untuk pemeriksaaan sitologi, seperti tes pap, setelah selesai memegang specimen, lepas sarung tangan dan cuci tangan.
9. Berikan lubrikan pada jari pemeriksa dengan air atau lubrikan yang larut air sebelum pemeriksaan bimanual.
10. Bantuwanita Kembali ke posisi duduk lalu berdiri, setelah pemeriksaan selesai
11. Sediakan tisu untuk menghapus lubrikan dari perinium
12. Berikan privasi bagi wanita saat berpakaian.

Pemeriksaan vulva sendiri, dilakukan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan preventif bagi wanita yang aktif secara seksual dengan usia 18 tahun atau lebih. Pemeriksaan vulva sendiri untuk menilai tanda dari infeksi menular seksual (IMS) atau tanda prekanker atau kanker. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh praktisi dan wanita secara bersamaan menggunakan kaca. Berikan diagram anatomi vulva pada

wanita yang akan melakukan pemeriksaan vulva dan diberikan instruksi untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi duduk dengan pencahayaan yang adekuat, memegang kaca dengan satu tangan dan tangan yang lain membuka jaringan sekitar inteitus vagina. Kemudian secara sistematis memeriksa mons pubis, klitoris, uretra, labia mayor, perinium, dan area perianal dan palpasi vulva. Perhatikan apakah terdapat perubahan yang abnormal seperti ulkus, benjolan, kutil, lentingan, lesi kulit, dan perubahan pigmentasi.

Tes Papanicolaou (Pap), kondisi karsinogenik, potensial atau nyata, dapat ditentukan melalui pemeriksaan sel dari serviks yang dikumpulkan selama pemeriksaan panggul. Dalam persiapan pastikan wanita belum melakukan bilas vagina, menggunakan pengobatan vagina, atau melakukan hubungan seksual selama 24 jam hingga 48 jam sebelum prosedur dilakukan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan pada waktu pertengahan siklus menstruasi. Jelaskan tujuan dari pemeriksaan dan sensasi yang akan dirasakan saat specimen diambil. Posisikan litotomi, speculum dimasukkan dalam vagina. Spesimen sitologi diambil sebelum pemeriksaan vagina dengan jari lainnya dilakukan atau spesimen bakteri dan endoserviks diambil. Swab kapas dapat digunakan untuk membersihkan secret serviks yang berlebihan sebelum specimen dikumpulkan.

Spesimen didapatkan dengan alat pengambil sample endoserviks (cytobrush, sikat serviks, papette atau sapu). Jika metode pengambilan sel dua sample digunakan cytobrush dimasukkan ke dalam kanal dan diputar sebanyak 30 hingga 180 derajat, diikuti dengan pulasan lembut dari seluruh zona transformasi menggunakan spatula. Alat sapu dimasukkan dan dirotasi 360 derajat sebanyak 5 kali. Alat ini mendapatkan sample endoserviks dan ekstroserviks pada waktu yang sama. Jika menggunakan teknik satu sisi, sample spatula diwarnai terlebih dahulu, kemudian pengambilan sample menggunakan cytobrush (memutar sikat dalam arah yang berlawanan dari arah pengambilan sebelumnya). Gelas sample kemudian disemprot dengan bahan pengawet selama 5 detik. Alat pengumpul direndam dalam cairan pengawet yang disediakan oleh laboratorium, kemudian ditutup rapat dan dikirim ke laboratorium. Berikan label nama, usia paritas, keluhan utama pada gelas sediaan atau vial. Catat tanggal pemeriksaan.

Pemeriksaan payudara sendiri, dilakukan Ketika payudara tidak nyeri atau bengkak. Cara pemeriksaan payudara sendiri:

1. Berbaring dan letakan bantal di bawah bahu kanan anda, letakan lengan kanan anda di bawah kepala.
2. Gunakan bantalan jari dari ketiga jari-jari tengah tangan kiri anda untuk meraba benjolan atau penebalan. Bantuan jari anda terletak pada ruas ketiga paling atas

- dari setiap jari. Gerakan bantalan jari anda secara melingkar untuk meraba jaringan payudara.
3. Tekan dengan cukup kuat untuk mengetahui bagaimana payudara anda teraba. Gunakan tekanan ringan untuk merasakan jaringan tepat di bawah kulit, tekanan sedang untuk yang lebih dalam, dan tekanan yang kuat dada dan iga. Penonjolan kenyal pada lingkaran bawah payudara normal terjadi,
 4. Lakukan pergerakan mengelilingi payudara dengan jalur tertentu, seperti menggunakan pola dari atas ke bawah atau garis vertikal. Gerakan ke atas menuju tulang klavikula dan ke bawah menuju iga dan dari bawah lengan di samping menuju ke tengah dada. Gunakan Teknik yang sama setiap saat.
 5. Sekarang periksa payudara kiri anda menggunakan bantalan jari-jari tangan kanan anda
 6. Jika pemeriksaan payudara dilakukan sambil berdiri di depan cermin, lihat apakah terdapat perubahan dari bentuk payudara anda, seperti cekungan pada kulit, perubahan puting susu, kemerahan atau bengkak.
 7. Jika pemeriksaan payudara dilakukan pada saat mandi. tangan anda yang bersabun akan mudah bergerak di atas kulit yang basah. hal ini akan memudahkan anda untuk memeriksa payudara anda.
 8. Memeriksa area di antara payudara dan bawah lengan serta area di bawah lengan itu sendiri sangat penting. Periksa area di atas payudara menuju tulang klavikula dan tahu Ketika anda sedang berdiri atau duduk dengan tangan diangkat.
 9. Jika anda menemukan adanya perubahan, segera datang ke pelayanan kesehatan.

F. Panduan Antisipasi Untuk Promosi Kesehatan Dan Pencegahan.

Pengetahuan sangat penting dalam mewujudkan kesehatan wanita, akan tetapi wanita juga perlu diyakinkan bahwa ia memiliki kebiasaan hidup sehat, meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, percaya tentang efikasi dan pencegahan, deteksi dini, terapi, dan latihan mandiri. Nutrisi yang baik juga harus dipertahankan, makanan yang rendah lemak jenuh, kolesterol, garam dan gula tidak berlebihan, biji-bijian, buah dan sayur. Tidak mengonsumsi berlebihan kopi, teh minuman ringan, dan minuman beralkohol. makanan yang disukai dan tidak disukai, kebiasaan makan, budaya dan tipe makanan, harus didiskusikan saat konseling.

Konseling aktivitas fisik dan olah raga untuk semua usia, perawat harus menekankan pentingnya olahraga setiap hari seumur hidup untuk manajemen berat badan dan promosi kesehatan. Olahraga yang menyenangkan bagi individu sangat diutamakan. Latihan kegel atau Latihan otot dasar panggul untuk menguatkan otot dasar panggul dalam pencegahan inkontinesia urine. Latihan ini juga bermanfaat

saat hamil dan setelah melahirkan, selain menguatkan otot dasar panggul, latihan ini menyanggah organ panggul dan mengontrol otot di sekeliling vagina dan uretra.

Latihan kegel dilakukan kurang lebih selama 15 menit setiap harinya. Disarankan dilakukan antara 24 dan 100 kontraksi per hari, namun hasil yang positif dapat dicapai dengan hanya 24-45 kontraksi sehari. Posisi pada pemula sebaiknya dengan berbaring terlentang dengan lutut ditekuk, atau bertumpu pada kedua tangan dan lutut, jika sudah terbiasa boleh melakukan dengan posisi berdiri atau duduk. Setiap kontraksi harus sekuat mungkin tanpa melakukan kontraksi pada perut, paha, atau pantat. Kontraksi harus ditahan selama 10 detik, dapat dimulai dengan menahan 2 detik setiap kontraksi sampai otot-ototnya lebih kuat. Istirahat dilakukan selama 10 detik atau lebih diantara kontraksi sehingga otot memiliki waktu Kembali ke bentuk semula dan setiap kontraksi dapat sekuat yang dapat dilakukan. Tarikan ke atas pada ketiga lapisan otot sehingga kontraksi mencapai tingkat paling tinggi dalam panggulnya.

Manajemen stres, perawat harus menilai tanda-tanda stres menggunakan kemampuan komunikasi terapeutik dalam menentukan faktor resiko. Perawat dapat membantu wanita menyadari pentingnya nutrisi yang baik, istirahat, relaksasi, dan olahraga atau pelarian dari masalah. Saran yang dapat dilakukan antaranya istirahat yang teratur, menyediakan waktu untuk berteman, membangun ketertarikan diluar pekerjaan atau rumah, menyusun tujuan yang realistik, belajar menerima diri apa adanya,

Intervensi untuk berhenti merokok meliputi *Ask* (tanya), *Assess* (kaji), *Advice* (saran), *Assist* (bantu), *Arrange follow-up* (atur tindak lanjut). *Ask* (tanya), umur berapa wanita tersebut mulai merokok? berapa jumlah rokok yang ia hisap setiap hari? kapan terakhir ia merokok? pernahkah ia mencoba untuk berhenti merokok? apakah ia mau berhenti merokok? *Assess* (kaji), alasan apa yang membuat tidak dapat berhenti merokok sebelumnya, apa yang membuat mulai merokok lagi? apakah ia memiliki seseorang untuk menolongnya? adakah orang lain yang merokok di rumah? apakah ia memiliki teman atau keluarga yang berhasil berhenti merokok?

Advice (sasaran), berikan informasi mengenai efek merokok pada kehamilan dan janinnya, bagi kesehatan dirinya di masa depan, dan bagi orang-orang yang tinggal Bersama dalam rumahnya. *Assist* (bantu), berikan dukungan, berikan materi pertolongan diri, dukung ia untuk membuat target waktu kapan ia akan berhenti, rujuk pada program berhenti merokok, atau berikan informasi mengenai produk pengganti nikotin (tidak dianjurkan saat hamil), ajarkan dan dukung penggunaan aktivitas untuk mengurangi stress, memberikan pengkajian kembali dengan melalui telpon atau kunjungan rumah. *Arrange follow up* (atur tindak lanjut), jadwalkan untuk memonitor status berhenti merokoknya, hubungi melalui telfon atau nilai setiap

kunjungan prenatal, berikan selamat atas kesuksesan dan dukungan jika Kembali merokok lagi.

G. Latihan Soal

SOAL PILIHAN GANDA

1. Organ genital luar adalah...
 - A. Uterus
 - B. Tuba Uterina
 - C. Ovarium
 - D. Vagina
 - E. Mons Pubis

2. Masa pertumbuhan lapisan endometrium yang berlangsung cepat kurang lebih hari ke lima sampai terjadi ovulasi. adalah..
 - A. Fase Menstruasi
 - B. Fase Proliferasi
 - C. Fase Sekretorik
 - D. Fase Iskemik
 - E. Fase Luteal

3. Kondisi karsinogenik, potensial atau nyata dapat ditentukan melalui pemeriksaan sel dari serviks adalah.....
 - A. Tes Papanicolaou (Pap)
 - B. Pemeriksaan panggul
 - C. Pemeriksaan Payudara Sendiri
 - D. Pemeriksaan Vulva
 - E. Pemeriksaan Dalam

4. Latihan kegel atau latihan dasar panggul bagi pemula sebaiknya dilakukan dengan posisi...
 - A. Berdir
 - B. Duduk
 - C. Bertumpu pada kedua lutut dan tangan
 - D. Berbaring terlentang dengan lutut ditekuk
 - E. Miring

5. Umur berapa mulai merokok? merupakan.....
- A. Ask
 - B. Assess
 - C. Advice
 - D. Assist
 - E. Arrange

Kunci Jawaban

- 1. E
- 2. B
- 3. A
- 4. D
- 5. A

Soal Essay

1. Seorang wanita, usia 50 tahun, datang ke pelayanan Kesehatan dengan keluhan mengalami flek-flek abnormal dan perdarahan vagina. Jelaskan pemeriksaan fisik yang tepat pada wanita tersebut dan promosi kesehatan yang perlu dilakukan.
2. Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke pelayanan kesehatan ingin memeriksakan kesehatannya karena takut penyakit kanker payudara. . Jelaskan pemeriksaan fisik yang tepat pada wanita tersebut dan promosi kesehatan yang perlu dilakukan.
3. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan tidak bisa menahan kencing. Jelaskan pengkajian yang tepat pada wanita tersebut dan promosi kesehatan yang perlu dilakukan
4. Seorang wanita berusia 37 tahun datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan belum mendapat keturunan, usia pernikahan sudah 11 tahun. Jelaskan pengkajian yang tepat pada wanita tersebut dan promosi kesehatan yang perlu dilakukan
5. Seorang wanita berusia 45 tahun datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan ingin berhenti merokok. Jelaskan pengkajian yang tepat pada wanita tersebut dan promosi kesehatan yang perlu dilakukan.

H. Rangkuman

- 1) Sistem reproduksi wanita meliputi organ genital internal dan organ genital eksternal
- 2) Siklus menstruasi wanita bergantung pada pengaturan umpan balik mekanisme hipotalamus-hipofisis ovarium
- 3) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wanita akan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan diantaranya budaya, agama, status sosioekonomi, kondisi personal, keunikan individu, dan tahap perkembangan
- 4) Pengkajian yang dilakukan secara komprehensif dapat dilakukan dengan tidak menuduh dan bersifat privasi
- 5) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara teratur meliputi Riwayat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, memberikan dasar dalam promosi kesehatan, pencegahan dini penyakit, dan rujukan
- 6) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit membantu wanita dalam meningkatkan kesehatannya, dengan cara meningkatkan motivasi, memberikan informasi, dan akses yang mudah dalam pelayanan kesehatan

I. Glossarium

Amenorea: Menstruasi tidak terjadi

Dismenorea: Menstruasi yang nyeri dimulai 2-6 bulan setelah menarche, berhubungan dengan ovulasi atau penyakit organ seperti endometriosis, penyakit radang panggul, neoplasma uterus

Fertilisasi: Bersatunya ovum dan sperma

Kolostrum: Air susu diawal, diproduksi setelah hamil 15 minggu kehamilan sampai sampai hari-hari pertama post partum, kadar protein dan lemak lebih tinggi dari pada air susu biasa, dengan efek laksatif untuk membersihkan meconium dan meningkatkan eksresi bilirubin

Latihan kegel: Latihan otot dasar panggul untuk menguatkan otot pubokoksigeal

Layanan telepon: Layanan bantuan via telepon, atau layanan konsultasi untuk diakses keluarga, paling sering untuk membantu perawatan bayi dan perawatan postpartum setelah pulang dari rumah sakit.

Metroragia: Perdarahan abnormal dari uterus, terutama jika terjadi kapan saja selain pada metode menstruasi

Menoragia: Aliran menstruasi abnormal yang banyak atau berlebihan

Menopause: Dari Bahasa Yunani *men* (bulan) dan *pausis* (berhenti), berhentinya siklus menstruasi secara permanen, didiagnosis setelah satu tahun tidak mengalami menstruasi

Ovulasi: Periode pematangan dan pelepasan ovum dari ovarium, biasanya 14 hari setelah menstruasi

Papanicolaou (Pap) Smear: Pemeriksaan mikroskopik dengan apusan serviks, endoserviks atau membrane mukosa lainnya yang menunjukkan adanya sel pra-maligna atau maligna dengan akurasi yang tinggi.

Pemeriksaan payudara sendiri (sadari): Pemeriksaan payudara secara sistematis oleh seorang wanita.

Pemeriksaan vulva sendiri: Pemeriksaan vulva secara sistematis oleh wanita sendiri

Perawatan prakonsepsi: Perawatan yang dirancang untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi semua pasien yang berpotensi hamil

Perimenopause: Periode transisi atau perubahan aktivitas ovarium sebelum menopause dan pada beberapa tahun pertama terjadi amenore

Posisi litotomi: Posisi di mana pasien berbaring terlentang dengan lutut difleksikan dan paha abduksi diangkat ke arah dada, suatu penyangga yang dipasang di meja pemeriksaan dapat digunakan untuk memfasilitasi pasien mengambil dan mempertahankan posisi ini.

Siklus menstruasi: Rangkaian kejadian yang kompleks yang terjadi secara simultan di endometrium, hipotalamus, dan hipofisis, dan ovarium yang menyebabkan persiapan kehamilan oleh uterus dan ovarium

Trimester: Pembagian kehamilan menjadi tiga periode yang masing-masing berlangsung selama sekitar tiga bulan.

J. Daftar Pustaka

Lowdermilk, D., L., Perry, S., E., & Cashion, K. (2013). Keperawatan Maternitas Edisi 8, buku 1. Ahli Bahasa Sidarta, F. & tania, A. Jakarta: Salemba Medika.

McKinney, E.S., James, S.R., Murray, S.S., Nelson, K.A., & Ashwill, J.W. (2018). Maternal-child nursing. Canada: Elsevier

BAB 3

MANAJEMEN KASUS PADA SISTEM REPRODUKSI (KLASIFIKASI KASUS SISTEM REPRODUKSI DAN PRIORITAS MASALAH SISTEM REPRODUKSI)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik , perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan
	CPL 2	Mampu menguasai ketrampilan umum pada bidang keilmuannya
	CPL 3	Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan
	CPL 4	Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien
	CPL 5	Mampu melaksanakan edukasi dengan ketrampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah
	CPL 7	Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan
	CPL 9	Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1,2	Memberikan asuhan keperawatan WUS, PUS, wanita dalam masa hamil, melahirkan dan setelah melahirkan dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita masa chilbearing dan masalah gangguan reproduksi
	CPMK 3	Mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan WUS, PUS, wanita dalam masa hamil,

		melahirkan dan setelah melahirkan dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita masa chilbearing dan masalah gangguan reproduksi
	CPMK 4,5	Melakukan tindakan keperawatan pada WUS, PUS, wanita dalam masa hamil, melahirkan dan setelah melahirkan dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita masa chilbearing dan masalah gangguan reproduksi
	CPL ⇒ Sub-CPMK	
	Sub CPMK 1,2	Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan komplikasi dan penyakit penyerta
	Sub CPMK	Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada ibu dengan persalinan berisiko
	Sub CPMK 1.2	Mahasiswa mampu mmberikan asuhan keperawatan pada ibu post partum dengan komplikasi
	Sub CPMK 1,2	Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada ibu dengan gangguan haid
	Sub CPMK 1,2	Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada ibu dengan infertilitas
	Sub CPMK 4,5	Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada gangguan reproduksi (infeksi, sel abnormalitas, keganasan)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan ,nifas diantara dua masa kehamilan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan proses keperawatan serta upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis ditatanan klinik maupun komunitas.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Konsep kehamilan dengan komplikasi 2. Kehamilan dengan penyakit penyerta 3. Kehamilan dengan penyakit menular seksual 4. Kehamilan dengan penyakit HIV 5. Kehamilan dengan infeksi virus Covid -19 6. Post partum dengan komplikasi 7. Gangguan reproduksi dengan infeksi 8. Keganasan organ-organ reproduksi 9. Gangguan haid 10. infertilitas	

	11. sel abnormalitas pada sistem reproduksi 12. Asuhan keperawatan ibu dengan sistem reproduksi mulai pengkajian sampai evaluasi
--	---

Pendahuluan:

Rata-rata wanita pernah mengalami vaginitis, baik pada remaja maupun wanita yang sudah menikah. Secara fisiologi vagina mengeluarkan sekret, pH normal pada vagina berkisar 3,5 – 4,5 pada keadaan patologis pH diatas 4,5 akibatnya mudah terkena infeksi pada vagina yang disebut vaginitis (Yuli, 2010). Infeksi vagina merupakan masalah yang penting bagi kesehatan wanita karena akan berdampak negatif bagi hubungan seksual dan keluarga (Sevil et al, 2013). Menurut World Health Association (WHO), setiap tahunnya sebanyak 10-15% wanita didunia mengalami vaginitis, angka prevalensi di tahun 2006 mencapai 25- 50% untuk kandidiasis, 20-40% untuk bakterial vaginosis, dan 15-51% untuk trikomoniasis. Di Indonesia pada Tahun 2007 angka prevalensi bakterial vaginosis mencapai 53% serta kandidiasis 3% (Kent, 1991). Salah satu akibat dari kejadian vaginitis yang terjadi 1 pada usia remaja adalah tingginya angka tidak masuk sekolah yang akan berdampak pada proses belajar mengajar (Kartika, 2015). Praktik vaginal hygiene merupakan tindakan awal menjaga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi pada remaja (Irianto, 2014). Perilaku remaja yang buruk mengenai vaginal hygiene, seperti perilaku yang buruk saat buang air besar (BAB) atau buang air kecil (BAK), membersihkan alat genital yang tidak bersih dan salah arah saat membersihkan vagina, pemakaian sabun untuk membersihkan vagina, pemakaian celana dalam yang ketat dan tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, jarang mengganti pembalut, tidak mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. Hal tersebut merupakan faktor pencetus terjadinya infeksi pada alat genital, salah satunya adalah vaginitis (Ratna, 2010). Salah satu hal yang memengaruhi tingkat vaginal hygiene remaja adalah tingkat sanitasi kamar mandi di sekolah. Di lingkungan sekolah, para remaja putri menggunakan kamar mandi secara bersamaan dan pemeliharaan sanitasi kamar mandi disekolah cenderung rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya ketersediaan air bersih sehingga membuat siswa hanya menggunakan tissue basah untuk membersihkan alat genital serta kamar mandi yang kebersihannya tidak dijaga rutin, sehingga hal ini menjadi faktor pencetus timbulnya infeksi.

Uraian Materi

Vaginitis adalah suatu inflamasi pada vagina yang mengubah lingkungan pada vagina. Vaginitis disebabkan oleh bakterial vaginosis, trikomoniasis, dan kandidiasis. Gejala vaginitis yang paling sering ditemukan yaitu keluarnya sekret yang abnormal dari vagina, dikatakan abnormal jika jumlahnya sangat banyak, bau menyengat atau disertai gatal-gatal atau nyeri. Cairan yang abnormal tampak lebih kental dibanding dengan cairan yang normal dan warnanya bermacam-macam, misalnya seperti keju, kuning kehijauan atau kemerahan. Vaginitis yang disebabkan oleh bakteri cenderung mengeluarkan cairan berwarna putih, abu-abu atau keruh kekuningan dan berbau amis. Setelah melakukan hubungan seksual atau mencuci vagina dengan sabun, bau cairannya semakin menyengat karena penurunan keasamaan vagina sehingga bakteri semakin banyak tumbuh (Irianto, 2014).

A. Konsep Dasar Vaginitis

1. Definisi

Kebanyakan wanita pemberitahuan dari waktu ke waktu bahwa mereka memiliki cairan dari vagina. Ini adalah proses normal yang menjaga daerah mukosa vagina lembab. Tetapi tidak hanya itu daerah vagina yang lembab bisa berubah menjadi sarang berkumpulnya bakteri-bakteri, jamur serta virus yang bisadengan mudah hidup di daerah tersebut dan bisa menimbulkan penyakit, seperti yang terdapat di daerah vagina yang biasa di sebut sebagai vaginitis. Vaginitis (colpitis) adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai bakteri, parasit atau jamur (Manuaba. 2001). Vaginitis adalah inflamasi vagina yang di cirikan oleh perubahan sekresi cairan vagina, yang dapat banyak, berbau, dan urulen, dan dapat diikuti oleh disuria dan pendarahan vagina. Sering terdapat gatal pada vulva, dan klien umumnya mengeluh ketidaknyamanan saat berkemih juga disporeunia (Black and Hawks, 2009).

2. Etiologi

Penyebab dari vaginitis adalah *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus vaginalis*. Penyebab lain meliputi gabungan bedak tabur, cacing kremi, benda asing, hygiene perineum yang buruk.

Menurut Universitas Padjadjaran (1981) penyebab vaginitis: 1) Vulvovaginitis pada anak 2) Sering disebabkan oleh gonorrhea atau corpus allienum. 3) Kolpitis senilis 4) Disebabkan karena ovaria berhenti berfungsi 5) Kolpitis pada masa reproduktif a. Masturbasi 4 b. Corpus allienum: pessarium, obat atau alat kontrasepsi kapas c. Rangsang themis seperti berenang dalam air

dingin 3. Klasifikasi Vaginitis Candida disebabkan oleh *Candida albicans*. Penyebab: 1.) Hygiene yang kurang. 2.) Pertumbuhan *Candida* yang berlebihan, karena kadar glukosa darah yang tinggi, dan pemberian 3.) Antibiotik berspektrum luas. Tanda dan gejala: (1) Pruritus vulvae. (2) Nyeri vagina yang hebat. (3) Disuria eksterna dan interna. (4) Rash pada vulva. (5) Eritematosa, Sekret khas seperti keju lembut. a. Vaginitis *Trichomonas* disebabkan oleh *Trichomonas vaginalis*. Penyebab hubungan seksual. Tanda dan gejala: 1.) Secret banyak dan bau busuk. 2.) Disuria eksterna dan interna. 3.) Pruritus vulva. 4.) Edema vulva. b. Vaginitis non spesifik disebabkan oleh *Gardnerella vaginalis*.

Penyebab : 1) Hygiene yang kurang. 2) Hubungan seksual. Tanda dan gejala: Vagina berbau busuk dan amis. 5 c. Vaginitis Atrofikan disebabkan oleh infeksi epitel vagina yang defisiensi estrogen. Penyebab pasca menopause rentan terhadap infeksi. Sekret encer, kuning sampai abu-abu.

3. Tanda dan gejala

- a. Pendarahan pervaginam.
- b. Disuria eksterna.
- c. Pruritus.
- d. Dispareunia.
- e. Permukaan vagina merah muda, pucat, halus tanpa rugae.

Menurut Manuaba (2001). 1) Vulvitis. 1) Infeksi kulit berambutnya. Terjadi perubahan warna. Membengkak. Terasa nyeri Kadang-kadang tampak bernanah. Menimbulkan kesukaran bergerak. 2) Infeksi kelenjar bartolini. Terletak dibagian bawah kulit. Warna kulit berubah. Membengkak. Terjadi timbunan nanah didalam kelenjar. Penderita sukar berjalan/duduk karena sakit.. 2) Vaginitis. a. Vaginitis *trichomonas vaginalis*. Disebabkan oleh *trichomonas vaginalis* yang mempunyai bentuk kecil, berambut getar dan lincah bergerak. Gejala utamanya: 1) Terdapat keputihan encer sampai kental. 6 2) Kekuning-kuningan. 3) Gatal dan terasa membakar. 4) Berbau. Pada pemeriksaan bidan akan menjumpai terdapat keputihan, ecer sampai kental dan terdapat bintik pada dinding vagina. Terdapat dispareunia. b. Vaginitis kandidiasis. Infeksi ini disebabkan oleh jamur *kandida albicans*. Vaginitis kandidiasis sering dijumpai pada wanita hamil, karena terdapat perubahan asam basa. Gejala vaginitis kandidiasis adalah terdapat keputihan kental bergumpal, terasa sangat gatal dan mengganggu, dan pada dinding vagina sering dijumpai membran putih yang bila dihapuskan dapat menimbulkan perdarahan.

4. Manifestasi klinis

Manifestasi vaginitis dicirikan dengan perubahan sekresi cairan vagina (leukorea yang berjumlah banyak, berbau, dan bersifat purulen, kadang disertai

dengan disuria dan perdarahan pada vagina. Wanita dengan vaginitis sering mengeluhkan gatal pada vulva, dan klien umumnya mengeluhkan ketidaknyamanan saat berkemih juga dispareunia (Black, J M dan Hawks, J H, 2014).

Menurut Sinklair & Webb (1992) dalam Febri (2014), manifestasi yang terdapat pada vaginitis dibagi menjadi dua yaitu : 1. Vaginitis Akut Pada sekitar vagina akan didapatkan pruritus, terasa panas, eritema, edema, perdarahan, nyeri (mungkin sangat, menyebabkan tidak mampu berjalan, duduk dan retensi urine akut), Ulserasi serta adanya vesikel. (Sinklair & Webb, 1992 dalam Febri, 2014). 2. Vaginitis Kronik 7 Jika vaginitis sudah dalam tahap kronik, didapatkan Inflamasi hebat dengan edema minimal, pruritus hebat dengan ekskoriasi, infeksi sekunder dengan daerah yang terserang : monpubis, perineum, paha yang berdekatan, anus, sekitar paha, lesi ulseratif disebabkan : granuloma, karsinoma, melanoma, dan hasil akhir mungkin berupa ekstruksi vulva (Sinklair & Webb, 1992 dalam Febri, 2014). Pada vaginitis trichomonas, gejala utamanya ialah fluor (keputihan) yang banyak, berbau amis dan berbusa, flour berwarna kehijauan sampai abu-abu dan fronthy appearance. Pada pemeriksaan mikroskopis dengan NaCl tampak banyak leukosit dan organisme berflagel niselule hidup dan motil (patognomonis). Gejala utama pada vaginitis yang disebabkan oleh clamidia, sama seperti vaginitis pada umumnya. Tanda klinis pada pemeriksaan mikroskopis dengan NaCl ditemukan leukosit banyak, tanpa clue cell, jamur atau trikhomonas. Sedangkan gejala pada vaginitis artofikan yang disebabkan oleh menopause, yang ditimbulkan ialah vagina gatal, kering, dispareunia, kadang perdarahan pervaginaan (Kurniawati, D dan Hanifah M, 2009). Perubahan patologis yang mendasari pada sindrom nefrotik adalah proteinuria, yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomerulus. Penyebab peningkatan permeabilitas ini tidak diketahui tetapi dihubungkan dengan hilangnya glikoprotein bermuatan negatif pada dinding kapiler. Mekanisme timbulnya edema pada sindrom nefrotik disebabkan oleh hipoalbumin akibat proteinuria. Hipoalbumin menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma sehingga terjadi transudasi cairan dari kompartemen intravaskuler ke ruangan interstitial. Penurunan volum intravaskuler menyebabkan penurunan perfusi renal sehingga mengaktifasi sistem reninangiotensin-aldosteron yang selanjutnya menyebabkan reabsorpsi natrium di tubulus distal 8 ginjal. Penurunan volum intravaskuler juga menstimulasi pelepasan hormon antidiuretik (ADH) yang akan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus kolektikus. Mekanisme terjadinya peningkatan kolesterol dan trigliserida akibat 2 faktor. Pertama, hipoproteinemia menstimulasi sintesis protein di hati termasuk

lipoprotein. Kedua, katabolisme lemak terganggu sebagai akibat penurunan 2 kadar lipoprotein lipase plasma (enzim utama yang memecah lemak di plasma darah).

5. Patofisiologi

Bila keseimbangan mikroorganisme berubah, maka organisme yang berpotensi patogen, yang merupakan bagian flora normal, misalnya *C. albicans* pada kasus infeksi monilia serta *G. vaginalis* dan bakteri anaerob pada kasus vaginitis non spesifik berproliferasi sampai suatu konsentrasi yang berhubungan dengan gejala. Pada mekanisme lainnya, organisme ditularkan melalui hubungan seksual dan bukan merupakan bagian flora normal seperti *Trichomonas vaginalis* dan *Neisseria gonorrhoea* dapat menimbulkan gejala. Gejala yang timbul bila hospes meningkatkan respon peradangan terhadap organisme yang menginfeksi dengan menarik leukosit serta melepaskan prostaglandin dan komponen respon peradangan lainnya. Gejala ketidaknyamanan dan pruritus vagina berasal dari respon peradangan vagina lokal terhadap infeksi *T. vaginalis* atau *C. albicans*. Organisme tertentu menarik leukosit, termasuk *T. vaginalis*, menghasilkan sekret purulen. Di antara wanita dengan vaginitis non spesifik. Baunya disebabkan oleh terdapatnya amonia dibentuk sebagai hasil metabolisme bakteri anaerob. Histamin dapat menimbulkan ketidaknyamanan oleh efek vasodilatasi lokal. Produk lainnya dapat merusak sel-sel epitel dengan cara infeksi lainnya.

6. Pemeriksaan Penunjang

- a. Pemeriksaan preparat basah Dilakukan dengan meneteskan satu atau dua tetes NaCl 0,9% pada sekret vagina diatas objek glass kemudian ditutup dengan coverglass. Diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 400x untuk melihat Clue cells
- b. Whiff test Dinyatakan positif jika bau amis timbul setelah penambahan satu tetes KOH 10-20% pada sekret vagina. Bau amis muncul sebagai akibat pelepasan amonia dan asam organik hasil dari bakteri anaerob (Srinivasan, 2008)
- c. Tes lakmus Kertas lakmus ditempatkan pada dinding lateral vagina. Ditemukan kadar pH > 4,5 (Srinivasan, 2008)

Pewarnaan gram Ditemukan penurunan jumlah *Lactobacillus* dan peningkatan jumlah bakteri anaerob (Srinivasan, 2008). Kultur vagina Kultur *Gardnerella vaginalis* Kurang bermanfaat untuk diagnosis bakterial vaginosis karena bakteri ini ditemukan hampir 50% pada perempuan normal (Srinivasan, 2008) Tes proline aminopeptidase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob, karena *Lactobacillus* Tidak menghasilkan zat tersebut. (Srinivasan, 2008). Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis bakterial vaginosis,

diantaranya adalah: 1) Kriteria Amsel Kriteria ini memiliki tingkat spesifitas yang lebih tinggi daripada pewarnaan gram. Kriteria ini paling sering digunakan untuk mendiagnosis vaginitis bakterial. Diagnosis dapat ditegakkan jika didapatkan minimal tiga dari empat kriteria. (Srinivasan, 2008). a) Secret vagina yang homogen, putih, dan tipis melekat pada vagina b) pH vagina > 4,5 Peningkatan pH dapat menyebabkan terlepasnya amin (trimetilamin). c) Secret vagina yang berbau amis setelah penambahan KOH jika didapatkan bau amis setelah menambahkan satu tetes 10- 20% KOH (potasium hidroksida) pada sekret vagina. d) Ditemukannya sel Clue pada pemeriksaan mikroskopis menggunakan preparat salin basah.

Pada pemeriksaan sampel pasien vaginitis bakterial didapatkan adanya peningkatan jumlah kuman Gardnerella. Sel squamosa normal memiliki ciri selnya runcing diujungnya, jernih, tepi yang lurus, sedangkan sel Clue memiliki ciri granular, tidak jernih, dan pinggir yang kasar. Sel Clue adalah sel epitel vagina yang batas tepinya sudah tidak terlihat jelas karena terdapat banyak bakteri yang menempel pada permukaan sel tersebut. Ditemukannya sel Clue pada 11 pemeriksaan mikroskopis memiliki sensitivitas 98% dan spesifitas 94,3% (Srinivasan, 2008).

7. Penatalaksanaan

Pencegahan Kebersihan yang baik dapat mencegah beberapa jenis vaginitis dari berulang dan dapat meredakan beberapa gejala: 1) Hindari bathtub dan pusean air panas spa. Bilas sabun dari luar daerah genital anda setelah mandi, dan keringkan area itu dengan baik untuk mencegah iritasi. jangan gunakan sabun wangi atau kasar, seperti yang dengan deodoran atau antiseptik 2) hindari iritasi. ini termasuk tampon dan bantalan berparfum. 3) usap dari depan ke belakang setelah menggunakan toilet. hindari penyebaran bakteri dari tinja ke vagina.

Hal-hal lain yang dapat membantu mencegah vaginitis meliputi; a) jangan gunakan douche. Vagina anda tidak memerlukan pembersihan lain dari mandi biasa. Berulang menggunakan douche mengganggu organisme normal yang berada di vagina dan dapat benar-benar meningkatkan risiko infeksi vagina. Douche tidak menghilangkan sebuah infeksi vagina. b) gunakan kondom lateks laki-laki. ini membantu mencegah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. c) Pakailah pakaian katun dan stoking dengan pembalut di selangkangannya. jika anda merasa nyaman tanpa itu, langsung mengenakan pakaian tidur. Ragi tumbuh subur di lingkungan lembab.

8. Komplikasi

Komplikasi yang dapat terjadi adalah timbulnya keputihan purulen terus-menerus disertai rasa nyeri (Roby, 2019). Prognosis pada penyakit vaginitis ini umumnya baik dan hampir semua dapat disembuhkan apabila diberikan pengobatan yang tepat serta konsumsi obat dengan teratur oleh pasien, pengobatan juga hendaknya diberikan sedini yg mungkin agar tidak sampai menimbulkan komplikasi, namun yang patut diwaspadai adalah terjadinya vaginitis yang berulang atau recurrent karena dapat menyebabkan peningkatan terjadinya komplikasi.

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Terdiri dari DS (data subyektif) dan DO (data obyektif). Data subyektif merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengkajian terhadap pasien atau keluarga pasien (apa yang dikatakan pasien atau keluarga pasien), sedangkan data tujuan adalah data yang diperoleh dari pemeriksaan.

a. Identitas:

Nama: sebagai identitas, upayakan agar petugas kesehatan memanggil dengan nama panggilan agar hubungan komunikasi menjadi lebih baik. Wanita lebih rentan terkena vaginitis dari pada laki-laki karena pada laki-laki itu tidak memiliki siklus menstruasi yang berisiko dialami keputihan.

Usia: Vaginitis dapat mempengaruhi perempuan dari segala usia 5) Anak usia 14 tahun 7) Reproduksi: 20-35 tahun 8) Menopause: > 55 tahun 13

Pendidikan untuk mengetahui tingkatan pengetahuan sehingga dalam memberikan pengasuhan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan klien

Agama sebagai dasar untuk memberikan dukungan mental dan spiritual terhadap klien dan keluarga

Suku data ini berhubungan dengan sosial budaya yang dianut oleh klien dan keluarga dan mempengaruhi pemberian konseling, informasi, dan edukasi

Status pernikahan untuk mengetahui status pernikahan pada klien, supaya diperoleh data yang spesifik

Alamat data ini untuk mengetahui tempat tinggal klien sehingga memudahkan pengkaji bila sewaktu-waktu memerlukan keterangan. Lebih lanjut tentang klien serta keadaan lingkungan klien yang dapat mempengaruhi kejadian vulvovaginitis.

b. Keluhan Utama

Merupakan jawaban terhadap pertanyaan, " masalah atau gejala apa yang membuat anda datang kesini saat ini?". Jika klien menyebutkan dari satu alasan, maka fokus pada salah satu hal yang menurutnya paling mengganggu.

c. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan sekarang Keluhan keluhan yang mungkin dirasakan pada sayatapi dengan vaginitis di antaranya: 1) Terdapat leukorea yang encer sampai kental, bewarna kekuning- kuningan dan agak berbau, keputihan yang meyebabkan rasa gatal yang membakar pada vulva dan vagina, kadang-kadang sersedang sakit saat BAK. (Terjadi pada usia reproduksi dengan pola seksual yang sering) Trikomonas. 2) Terdapat leukorea berwarna keputih-putihan dan vulva sangat gatal, pada dinding vulva dan vagina juga terdapat selaput- selaput kecil berwarna putih (Terjadi pada anak/pubertas dan juga pada masa reproduksi) -Kandida albicans. 3) Terdapat leukorea berwarna putih bersemu kelabu, kadangkadang kekuningan dengan bau yang kurang sedap, terasa gatal →Vaginitis hemofilusvaginalis. 4) Terdapat leukorea dan rasa gatal hingga pedih, disuria dan sering kencing (Terjadi pada masmenopause) atrofikan. Vulvovaginitis

Riwayat Kesehatan sebelumnya Penyakit infeksi (campak, gondongan, batuk rejan, cacar air, demam rematik, difteria, polio, TBC, hepatitis, 33 meningitis), penyakit kronis dan sistemik (diabetes melitus, artritis, stroke, tiroid, hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung, kanker, anemia, bulan sabit), kecelekaan dan perlukaan, operasi, pembedahan, rawat inap, transfusi darah, riwayat imunisasi (BCG, polio, DPT, hepatitis, campak, MMR, Varicela, influenza, vaksin pneumokokus, uji tuberkulin, TB terakhir), pemeriksaan skrinning terakhir (tes pap, mamogram, uji samar darah tinja, sigmoidoskopi atau kolonoskopi, hematokrit, hemoglobin, titer rubela, urinalisis, tes kolesterol, EKG, penglihatan terakhir, gigi dan pemeriksaan pendengaran), pengobatan saat ini (nama obat, dosis, frekuensi, durasi, alasan konsumsi, penolakan terhadap pengobatan, pengobatan rumah, penggunaan obat yang dijual bebas, vitamin, suplemen/mineral jamu yang digunakan dalam jangka waktu 24 jam).

Riwayat perkawinan Usia perkawinan, lama perkawinan ke berapa? 5) Riwayat kebidanan A. Riwayat mensturasi (usia saat menarche, periode, mensturasi terakhir, pola menstruasi, keluhan atau gejala yang dirasakan menjelang, saat dan setelah mensturasi. panjang siklus durasi jumlah darah. Intermenstrual, pendarahan, sifat darah (warna, bau, cair/gumpalan). B. Perimenopause atau menopause (pola pendarahan, gejala vasomotor. Terapi penggantian hormon yang digunakan).

Kontrasepsi (metode sekarang, kepuasan dengan metode yang digunakan, metode komplikasi, alasan dihentikan).

Riwayat kebidanan sebelumnya, termasuk Riwayat kehamilan, riwayat persalinan, abortus dan nifas sebelumnya, masalah kesehatan selama kehamilan, persalinan dan nifas terdahulu, riwayat kehamilan sekarang (klien merasa hamil berapa bulan, keluhan waktu hamil, bergerak anak pertama dirasakan, dirasakan imunisasi, penyakit BB selama hamil, pemeriksaan 34 kehamilan, teratur atau tidak teratur, tempat pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan).

Riwayat keluarga Informasi mengenai usia, kesehatan dan kematian anggota keluarga yang diterjemahkan melalui genogram. Anamnesis adanya riwayat diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, atau masalah pernafasan, ginjal, tiroid, kanker dan gangguan pendarahan, hepatitis, alergi, asma, ateriitis, TBC, epilepsi, penyakit mental, infeksi HIV.

d. Pemeriksaan terhadap terjadinya kekerasan

- 1) Pernahkah klien dipukul, ditendang ditampar, dipaksa berhubungan seks yang tidak diinginkan?
- 2) Pernahkah klien mengalami kekerasan verbal/emosional?
- 3) Apakah klien mengalami kekerasan pada usia anak-anak? Jika ya sudahkah menerima klien konseling ataukah klien perlu dirujuk?

e. Pola kebutuhan fungsional

Perubahan mencukupi aktifitas sehari-hari (nutrisi; diet, kafein, nikotin, alkohol, obat-obatan terlarang atau retrosional; eliminasi, pribadi kebersihan, istirahat tidur, bekerja, aktifitas, keteraturan olahraga, seksualitas, apakah aktif secara seksual? dengan pria, wanita klien atau keduanya? Apakah perilaku seks yang mengurangi risiko? b. Pola persepsi manajemen perdarahan kesehatan, pola koping dan stres, pola nilai dan keyakinan yang dianut, pola konsep diri dan persepsi diri, pola komunikasi.

f. Lingkungan

Kondisi rumah sekolah, tempat bekerja, tempat bermain pajanan terhadap panas atau dingin yang ekstrim, racun industri (asbes, timbal, spesifik), radiasi tinja kucing atau asap rokok.

g. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik terutama dilakukan pada daerah genitalia dan sekitarnya, yang dilakukan di ruang periksa dengan lampu yang cukup terang. Lampu sorot tambahan diperlukan untuk pemeriksaan pasien perempuan dengan spekulum. Dalam pelaksanaan sebaiknya pemeriksa didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain. Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan,

pemeriksa didampingi oleh paramedis perempuan, sedangkan pada pemeriksaan pasien laki-laki, dapat didampingi oleh tenaga paramedis laki-laki atau perempuan. Beri penjelasan lebih dulu kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan: a. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik alat kelamin dan sekitarnya, pemeriksa harus selalu menggunakan sarung tangan. Jangan lupa Mencuci tangan sebelum dan sesudah memeriksa. b. Pasien harus membuka pakaian di dalamnya agar dapat dilakukan pemeriksaan alat kelamin (pada keadaan tertentu, kadang-kadang-kadang pasien harus membuka seluruh pakaiannya secara bertahap). 1) Pasien perempuan, diperiksa dengan berbaring di meja pemeriksaan dalam posisi litotomi. A) Pemeriksa duduk dengan nyaman ambil melakukan. Pemeriksaan dan palpasi mons pubis, labia, dan perineum. B) Periksa daerah genitalia luar dengan memisahkan ke dua labia, perhatikan adakah kemerahan, pembengkakan, luka/lecet, massa, atau duh tubuh. C) Melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah genitalia, perineum, anus dan sekitarnya. D) Jangan lupa memeriksa daerah inguinal untuk mengetahui pembesaran kelenjar getah bening setempat (regional). E) Bilamana tersedia fasilitas laboratorium, sekaligus Dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan 2) Pemeriksaan spekulum Pasien perempuan dengan status sudah menikah, dilakukan pemeriksaan pengambilan spesimen dengan spekulum serta a. Beri penjelasan lebih dulu mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan agar pasien tidak merasa takut. b. Bersihkan terlebih dahulu dengan kain kasa yang telah. Kondisi larutan NaCl. c. Setiap pengambilan bahan harus menggunakan spekulum. Steril (sesuaikan ukuran spekulum dengan riwayat kelahiran per vaginam), usap atau sengkeli steril. d. Masukkan daun spekulum steril dalam keadaan tertutup Dengan posisi tegak vertikal ke dalam vagina, dan setelahnya seluruhnya masuk kemudian putar pelan-pelan sampai daun. spekulum dalam posisi datar/horizontal. Buka spekulum dan dengan bantuan lampu sorot vagina cari serviks. Kunci spekulum pada posisi itu sehingga serviks terfiksasi. e. Setelah itu dapat dimulai pemeriksaan serviks, vagina dan pengambilan spesimen 1. Dari serviks: bersihkan daerah endoserviks dengan kasa steril, kemudian ambil spesimen duh tubuh serviks dengan sengkeli/swab Dacron steril untuk pembuatan. Sediaan hapus, dengan usap Dacron yang lain dibuat sediaan biakan. 2. Dari fornix posterior: dengan sengkeli/swab Dacron™ steril untuk pembuatan sediaan basah, dan lakukan tes amin. 3. Dari dinding vagina: dengan kapas lidi sengkeli steril untuk sediaan menghapus. 4. Dari uretra: dengan sengkeli steril untuk menghapus sediaan F) Cara melepaskan spekulum kunci spekulum terlepas, sehingga spekulum dalam posisi tertutup, putar spekulum 90 sehingga daun spekulum

dalam posisi tegak, dan keluarkan spekulum perlahan-lahan. Pada pasien perempuan berstatus belum menikah tidak dilakukan pemeriksaan dengan spekulum, karena akan merusak selaput daranya sehingga bahan pemeriksaan hanya diambil dengan sengkeli steril dari vagina dan uretra. Untuk pasien perempuan yang belum menikah namun sudah aktif berhubungan seksual, diperlukan informed consent sebelum melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Namun bila pasien menolak pemeriksaan dengan spekulum, pasien ditangani menggunakan bagan alur tanpa spekulum.

h. Diagnosa

Kemungkinan diagnosis perdarahan pada klien dengan Vaginitis adalah sebagai berikut: 1. Nyeri akut berhubungan dengan merespons inflamasi kerusakan jaringan, suplay terapi/tindakan. vaskularisasi atau efek samping 2. Kurangnya volume cairan berhubungan dengan mual. Muntah, asupan tidak memadai. 3. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanik (menggaruk) lesi pada mukosa vagina.

i. Perencanaan

1) **Nyeri akut berhubungan dengan merespons inflamasi kerusakan jaringan, suplay terapi/tindakan.** vaskularisasi atau efek samping 20

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan pembedahan menimbulkan nyeri mengurangi/dapat teratasi **Kriteria Hasil:** A. Melaporkan rasa nyeri yang sudah teratasi (rasa nyeri berkurang) B. Dapat mendemonstrasikan keterampilan relaksasi dan aktivitas pengalih perhatian sesuai situasi individu. **Rencana tindakan:** A. Kaji riwayat nyeri seperti lokasi, frekuensi; durasi dan intensitas (skala 1-10) dan upaya untuk mengurangi nyeri. Rasional: Informasi merupakan data dasar untuk evaluasi diatau efektifitas intervensi yang dilakukan. Pengalaman nyeri setiap individu bervariasi karena mengganggu fisik dan psikologi. B. Beri kenyamanan dengan mengatur posisi klien dan pengalihan aktivitas. Rasional: Menolong dan meningkatkan relaksasi dan refokus C. Dorong pengguna an manajemen stres seperti tehnik relaksasi, visualisasi, komunikasi terapeutik melalui sentuhan. Rasional Melibatkan dan memberikan partisipasi aktif untuk meningkatkan kontrol D. Evaluasi/Kontrol menguranginya rasa nyeri. Sesuaikan pemberian medikasi sesuai kebutuhannya Rasional Tujuan umum/maksimal mengontrol tingkat nyeri dan minimal ada keterlibatan dalam ADLs. E. Kolaborasi: mengembangkan rencana manajemen penanganan sakit dengan klien dan dokter. Beri analgetik sesuai indikasi dan dosis yang tepat. Rasional Rencana terorganisasi dan meningkatkan

kesempatan dalam mengontrol rasa sakit. Klien harus berpartisipasi aktif dalam perawatan di rumah.

- 2) **Kurangnya volume cairan berhubungan dengan mual, muntah, asupan yang tidak memadai. Tujuan dan kriteria hasil:** Setelah dilakukan tindakan perawatan selamax24 jam Diharapkan kebutuhan cairan terpenuhi dengan **Kriteria Hasil:** A. TTV biasa saja B. Turgor kulit baik C. Haluaran urin tepat secara individu D. Kadar elektrolit dalam batas normal. **Rencana tindakan:** A. Catat intake dan output secara akurat. Pantau tanda tanda vital, catat adanya perubahan tanda penting. Rasional: hipovolemia dapat diwujudkan oleh hipotensi dan takikardi B. Kaji Kaji nadi perifer, pengisian kapiler, turgor kulit dan membran mukosa Rasional demam dengan kulit kemerahan, kering menunjukkan dehidrasi. C. Berikan Pantau masukan dan pengeluaran cairan. **Rasional** merupakan indikator dari dehidrasi, memberi perkiraan akan cairan pengganti, fungsi ginjal, dan program pengobatan. D. Tahan untuk memberikan cairan paling sedikit 2500 ml/hari dalam batas yang dapat ditoleransi jantung. Rasional mempertahankan volume sirkulasi. a. Berikan terapi cairan parenteral, pantau pemeriksaan laboratorium(Ht, BUN, Na, K) 22 Rasional: mempercepat proses penyembuhan untuk memenuhi kebutuhan cairan
- 3) **Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis (menggaruk) lesi pada mukosa vagina. Tujuan:** Setelah dilakukan tindakan penghentian menyebabkan kerusakan Integritas kulit dapat teratasi. **Kriteria Hasil:** A. TTV dalam rentang normal B. Turgor kulit baik C. Tidak ada eritema D. Lesi berkurang **Rencana tindakan:** a) Ukur tanda-tanda vital. Rasional: Untuk mengetahui derajat keadekuatannya perfusi jaringan dan menentukan intervensi selanjutnya. b) Anjurkan klien untuk tidak menggaruk area yang mengalami gatal. **Rasional:** mencegah terjadinya luka dan infeksi. c) Ajarkan klien dan keluarga tentang perawatan kebersihan vulva. Rasional meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga tentang kebersihan genitalia. d) Pantau tanda-tanda infeksi seperti bau, eritema, dan demam Rasional menjuluki tanda-tanda infeksi. e) Kolaborasi pemberian antibiotik topikal. Rasional mengatasi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme penyebab vaginitis.

j. Implementasi

Implementasi penghentian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang menghadap status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Gordon, 1994, dalam Potter & Pertrahun 1997). 5. Evaluasi

Tahap penilaian atau evaluasi adalah evaluasi yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan. Lainnya. Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai.

C. Latihan Soal

1. Seorang ibu G2 P1 A0 hamil 27 minggu datang ke Puskesmas datang untuk memeriksakan kehamilannya, anak pertama berusia 2,5 tahun. Ibu mengeluh kadang merasa pusing sudah beberapa minggu ini, gerakan janin cukup aktif. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 2 jari diatas pusat, DJJ 140 x/mnt, edema wajah tidak ada, edema pada pretibia, TD 140/95 mmHg. Apakah pemeriksaan diagnostik tambahan yang dapat dilakukan ?
 - A. Kimia darah
 - B. Protein Urin
 - C. Darah lengkap
 - D. Berat jenis urin
 - E. Gula darah sewaktu
2. Seorang Wanita berusia 21 tahun G2P0A1 post partum hari ke-5 datang ke poli klinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Dari hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan yang berwarna dari daerah jahitan episiotomi. Pada saat observasi tanda-tanda vital di dapat TD 120/70mmHg, frekuensi Nadi 88 x/menit, frekuensi napas 20x/menit, suhu 380C, pasien mengatakan rentan skala nyeri 5 dari rentan 1-10. Apakah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut?
 - A. Pemeriksaan tanda REEDA
 - B. Pemeriksaan Perdarahan Pervagina
 - C. Pemeriksaan involusio Uteri
 - D. Pemeriksaan Darah Lengkap
 - E. Pemeriksaan USG abdomen
3. Seorang ibu 27 tahun, G2 P1 A0 hamil 38 minggu, datang ke puskesmas pukul 16.00. Kemudian dilakukan pemeriksaan didapatkan TFU 36 cm, ibu mengeluh sudah mulas-mulas namun belum teratur sejak 10 jam yang lalu. Ibu mengatakan mules-mules 2-3x setiap 10 menit selama 20 detik, selain itu ibu juga mengeluh sudah keluar lendir bercampur darah. Saat dilakukan periksa dalam sudah ada pembukaan 2 cm, serviks tipis dan mendatar, ibu meringis. Apakah Diagnosa keperawatan utama pada kasus diatas ?
 - A. Cemas berhubungan dengan mulainya persalinan
 - B. Nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi

- C. Risiko infeksi berhubungan dengan adanya pembukaan serviks
 - D. Defisit volume cairan berhubungan dengan peningkatan output cairan
 - E. Risiko ketidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran pervaginam
4. Seorang perempuan berusia 26 tahun P1A0 berada di ruang nifas dengan keluhan rasa nyeri pada daerah kemaluan. Hasil pengkajian terdapat luka episiotomi, kemerahan, edema, dan sekresi negatif, TD110/70mmHg, frekuensi napas 20x/menit dan frekuensi nadi 88x/menit Apakah tindakan utama pada kasus?
- A. Vulva hygiene
 - B. Edukasi cara perawatan luka
 - C. Rawat luka episiotomi
 - D. Mobilisasi dini
 - E. Berikan Nutrisi Adekuat
5. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke poli KIA dengan keluhan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Hasil pengkajian pasien sering mengalami keputihan, gatal, warna kehijauan, konsistensi kental dan berbau. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus?
- A. Usapan vagina
 - B. Colposkopi
 - C. USG transvaginal
 - D. Biopsi
 - E. Pap smear

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. A
- 3. B
- 4. C
- 5. E

D. Rangkuman Materi

1. Definisi Manajemen Kasus pada Sistem Reproduksi

Manajemen kasus pada sistem reproduksi merupakan pendekatan terkoordinasi dan sistematis dalam menangani berbagai gangguan dan masalah kesehatan reproduksi. Pendekatan ini melibatkan proses identifikasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi berbagai layanan dan sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk menangani masalah reproduksi secara efektif dan efisien.

2. Pentingnya Manajemen Kasus yang Tepat

Manajemen kasus yang tepat dalam sistem reproduksi sangat penting karena:

- a. Membantu mengidentifikasi masalah secara dini sehingga dapat mencegah komplikasi lebih lanjut
- b. Memastikan kontinuitas perawatan yang komprehensif dan terintegrasi
- c. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan
- d. Mengoptimalkan hasil kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien
- e. Mengurangi biaya kesehatan dengan mencegah komplikasi dan rawat inap yang tidak perlu
- f. Mempertahankan fungsi reproduksi dan fertilitas

3. Ruang Lingkup Manajemen Kasus Reproduksi

Manajemen kasus sistem reproduksi mencakup spektrum luas kondisi kesehatan yang meliputi:

- a. Kesehatan reproduksi pria dan wanita
- b. Gangguan hormonal dan struktural
- c. Infeksi dan penyakit menular seksual
- d. Keganasan pada organ reproduksi
- e. Masalah kesuburan dan infertilitas
- f. Masalah kesehatan reproduksi pada berbagai tahap kehidupan (remaja, dewasa, dan lansia)
- g. Kesehatan maternal dan perinatal

4. Klasifikasi Kasus Sistem Reproduksi

Kasus Sistem Reproduksi Pria

a. Gangguan Hormonal

1) Hipogonadisme

- Definisi: Kondisi di mana testis tidak memproduksi jumlah hormon testosteron atau sperma yang cukup.
- Klasifikasi: Hipogonadisme primer (masalah pada testis) dan sekunder (masalah pada hipotalamus atau hipofisis).
- Manifestasi: Perkembangan seksual terhambat, disfungsi ereksi, infertilitas, penurunan massa otot, osteoporosis, dan perubahan mood.

- Pendekatan: Evaluasi hormonal, terapi penggantian testosteron, stimulasi hormon gonadotropin untuk infertilitas.
- 2) Disfungsi Tiroid yang Mempengaruhi Reproduksi
- Hipotiroidisme dapat menyebabkan penurunan libido, disfungsi ereksi, dan gangguan spermatogenesis.
 - Hipertiroidisme dapat menyebabkan ejakulasi dini, ginekomastia, dan penurunan kualitas sperma.
 - Pendekatan: Normalisasi fungsi tiroid dan evaluasi dampak pada sistem reproduksi.
- b. Gangguan Spermatogenesis
- 1) Oligospermia
- Definisi: Konsentrasi sperma yang rendah (<15 juta/ml).
 - Etiologi: Varikokel, infeksi, paparan lingkungan, kelainan genetik, obat-obatan, atau idiopatik.
 - Pendekatan: Identifikasi dan pengobatan penyebab yang mendasari, suplementasi antioksidan, teknik reproduksi berbantu jika diperlukan.
- 2) Azoospermia
- Definisi: Tidak adanya sperma dalam ejakulat.
 - Klasifikasi: Azoospermia obstruktif (masalah pada saluran) dan non-obstruktif (masalah pada produksi sperma).
 - Pendekatan: Evaluasi hormonal, biopsi testis, aspirasi sperma mikro-epididimis, fertilisasi in vitro dengan injeksi sperma intrasitoplasma (ICSI).
- c. Gangguan Anatomis
- 1) Varikokel
- Definisi: Pembesaran pembuluh darah vena di dalam skrotum.
 - Dampak: Peningkatan suhu skrotum yang mengganggu produksi sperma, stres oksidatif, dan infertilitas.
 - Pendekatan: Varikokelektomi untuk kasus simptomatik atau berhubungan dengan infertilitas.
- 2) Kriptorkidisme
- Definisi: Kondisi di mana satu atau kedua testis tidak turun ke dalam skrotum.
 - Komplikasi: Infertilitas, atrofi testis, dan peningkatan risiko kanker testis.
 - Pendekatan: Terapi hormonal atau pembedahan (orkidopeksi) sebelum usia 1-2 tahun untuk mencegah kerusakan permanen.
- d. Gangguan Fungsi Seksual
- e. Infeksi Sistem Reproduksi
- 1) Penyakit Radang Panggul (PRP)
- Definisi: Infeksi saluran reproduksi atas (uterus, tuba falopi, ovarium).

- Etiologi: Umumnya infeksi menular seksual (*N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*).
 - Komplikasi: Abses tubo-ovarium, infertilitas tubal, kehamilan ektopik, nyeri pelvis kronis.
 - Pendekatan: Antibiotik kombinasi luas spektrum, rawat inap untuk kasus berat, drainase abses jika ada.
- 2) Vaginitis
- Etiologi: Bakteri (bacterial vaginosis), jamur (kandidiasis), parasit (trikomoniasis).
 - Pendekatan: Identifikasi patogen spesifik dan terapi antimikroba yang sesuai.
- 3) Servitis
- Definisi: Peradangan pada serviks.
 - Etiologi: Infeksi (*N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*) atau non-infeksi.
 - Pendekatan: Antibiotik untuk kasus infeksi, manajemen gejala untuk kasus non-infeksi.
- f. Gangguan pada Masa Kehamilan
- 1) Abortus
- Definisi: Penghentian kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin <500 gram.
 - Klasifikasi: Spontan (imminens, insipiens, inkomplit, komplit) dan diinduksi (medis, bedah).
 - Pendekatan: Evakuasi sisa jaringan, pencegahan infeksi, dukungan psikologis, evaluasi kausal untuk abortus berulang.
- 2) Kehamilan Ektopik
- Definisi: Implantasi embrio di luar kavum uteri (umumnya di tuba falopi).
 - Faktor risiko: Riwayat PRP, bedah tuba, riwayat kehamilan ektopik sebelumnya.
 - Kegawatdaruratan: Ruptur tuba dengan perdarahan intraabdominal.
 - Pendekatan: Terapi medis (metotreksat) untuk kasus stabil, bedah (laparoskopi/laparotomi) untuk kasus tidak stabil atau besar.
- 3) Preeklampsia/Eklampsia
- Definisi: Hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) dan proteinuria yang muncul setelah 20 minggu kehamilan.
 - Komplikasi: Eklampsia (kejang), sindrom HELLP, solusio plasenta, gangguan pertumbuhan janin.
 - Pendekatan: Pemantauan ketat, antihipertensi, magnesium sulfat untuk pencegahan kejang, terminasi kehamilan untuk kasus berat.

4) Diabetes Gestasional

- Definisi: Intoleransi glukosa yang muncul atau terdeteksi pertama kali selama kehamilan.
- Komplikasi: Makrosomia, distosia bahu, hipoglikemia neonatal, peningkatan risiko seksio sesarea.
- Pendekatan: Modifikasi diet, aktivitas fisik, pemantauan gula darah, insulin jika diperlukan.

E. Glosarium

Epigastrium	: bagian perut sebelah atas, di antara ujung tulang dada dan pusat perekaman berkelanjutan denyut jantung janin yang diperoleh melalui transduser ultrasonografi yang dipasang di perut ibu.
kardiotokografi (CTG)	: CTG banyak digunakan selama kehamilan sebagai metode untuk menilai kesejahteraan janin, terutama pada kehamilan dengan risiko komplikasi yang meningkat prosedur obstetri untuk memperpanjang masa gestasi pada pasien, yang sebagian mengalami persalinan prematur
Tokolisis	: Hal ini dicapai melalui berbagai pengobatan yang untuk menghambat kontraksi otot polos uterus. Pengobatan utama yang digunakan adalah reseptor agonis beta adrenergik, penghambat saluran kalsium, penghambat siklooksigenase, magnesium sulfat.

F. Daftar Pustaka

- Ambarwati. (2009). Asuhan Kebidanan Nifas. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press.
- Anggraini. (2010). Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Asih. (2016). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Lowdermilk, B., & Jensen. (2006). Buku Ajar Keperawatan Maternitas Alih bahasa Maria A.Wijayani, Peter I.Anugrah (4 ed.). Jakarta: EGC.
- Perinasia. (2009). *Manajemen Laktasi Persalinan Dan Bayi-Bayi Lahir Sehat* (2 ed.). Jakarta.

- Rahayu, D., Santoso, B., & Yunitasari, E. (2015, -). Produksi Asi ibu dengan intervensi acupresure point location dan pijet oksitosin. *Jurnal ners*, 10(1), -.
- RI, D. (2007). *Manajemen Laktasi*. Jakarta: RI.
- Rukmawati, S., Astutik, P., & Retnoningrum, A. D. (2020). Method (Stimulation Endorphin, Oxytosin and Sugestive) to Increase The Production of Breast Milk and Involution of Uters On Post Partum. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 1207-1211.

BAB 4

TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN MATERNITAS TERKAIT MASALAH KESEHATAN WANITA

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan terkait anemia, KEK, dan abortus pada ibu hamil, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkontribusi dalam pencegahan serta penanganannya.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

- Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan klasifikasi anemia serta KEK pada ibu hamil dan abortus.
- Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis anemia yang sering terjadi pada ibu hamil dan kaitannya dengan KEK dan abortus.
- Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan anemia dan KEK pada ibu hamil dengan risiko abortus.
- Mahasiswa dapat menganalisis data prevalensi anemia dan KEK pada ibu hamil di Indonesia berdasarkan sumber terpercaya.
- Mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap anemia, KEK, dan abortus pada ibu hamil.
- Mahasiswa dapat melakukan pengkajian tanda-tanda dan gejala anemia serta KEK pada ibu hamil secara sistematis.
- Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan sesuai kebutuhan ibu hamil dengan anemia, KEK, dan risiko abortus.
- Mahasiswa dapat memberikan edukasi yang efektif kepada ibu hamil mengenai pencegahan dan penanganan anemia, KEK, serta upaya pencegahan abortus.
- Mahasiswa dapat mengevaluasi hasil intervensi pada ibu hamil dengan anemia, KEK, dan abortus untuk menentukan langkah lanjutan.
- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap empati dan peduli dalam memberikan asuhan keperawatan kepada ibu hamil dengan anemia, KEK, dan risiko abortus.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, klasifikasi, dan jenis anemia serta KEK pada ibu hamil.
- Mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara anemia, KEK, dan risiko abortus berdasarkan data prevalensi dan literatur terkini.
- Mahasiswa memahami mekanisme fisiologis dan patologis yang mendasari anemia, KEK, dan abortus.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap anemia, KEK, dan abortus pada ibu hamil.
- Mahasiswa dapat merancang rencana intervensi berbasis bukti untuk menangani anemia dan KEK guna mencegah abortus.

Psikomotor

- Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara sistematis terhadap tanda dan gejala anemia serta KEK pada ibu hamil.
- Mahasiswa dapat mengukur dan mengevaluasi status gizi ibu hamil dengan metode antropometri dan pemeriksaan klinis.
- Mahasiswa mampu melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien yang mengalami anemia dan KEK.
- Mahasiswa dapat menyusun dan menyampaikan edukasi yang efektif kepada ibu hamil tentang pencegahan anemia, KEK, dan risiko abortus.
- Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian, intervensi, dan evaluasi dengan tepat dan akurat sesuai standar keperawatan.

Afektif

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian dan empati terhadap kondisi ibu hamil yang mengalami anemia, KEK, atau risiko abortus.
- Mahasiswa menunjukkan sikap profesional dan etis dalam memberikan asuhan keperawatan.
- Mahasiswa menghargai pentingnya edukasi kesehatan dalam pencegahan anemia dan KEK pada ibu hamil.
- Mahasiswa berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil melalui intervensi yang berpusat pada pasien.

Pendahuluan

Anemia, Kurangnya Energi Kronik (KEK), dan abortus merupakan isu kesehatan maternitas yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 48,9%, menunjukkan bahwa hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia mengalami kondisi ini. Anemia tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi seperti KEK dan abortus. Abortus, baik spontan maupun provokatus, sering kali terjadi akibat kondisi kesehatan ibu yang tidak optimal, termasuk anemia dan KEK. Selain itu, KEK pada wanita usia subur juga menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi status gizi ibu hamil dan pertumbuhan janin.

Buku ajar ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan berbasis bukti kepada mahasiswa keperawatan. Pengetahuan tentang anemia, KEK, dan abortus sangat penting bagi mahasiswa keperawatan agar dapat memahami faktor risiko, prevalensi, dampak, dan intervensi yang relevan dengan ketiga isu tersebut. Buku ini tidak hanya memberikan dasar teori tetapi juga memfasilitasi pembaca dengan latihan, studi kasus, dan pendekatan pembelajaran aktif.

Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari berbagai topik, seperti jenis-jenis anemia yang umum terjadi pada ibu hamil, faktor risiko KEK, hubungan antara anemia dan abortus, serta strategi pencegahan dan intervensi keperawatan yang holistik. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis bukti, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis dan praktis dalam menangani masalah kesehatan maternitas.

Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan teori dan praktik ke dalam asuhan keperawatan, memberikan edukasi kesehatan yang efektif kepada ibu hamil, dan menunjukkan sikap profesional yang empati dalam menangani kasus-kasus terkait anemia, KEK, dan abortus. Buku ini menjadi salah satu alat penting bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas serta mortalitas ibu dan bayi di Indonesia.

Uraian Materi

Topik yang akan dibahas dalam materi ini mencakup hubungan antara anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan abortus pada ibu hamil, yang merupakan masalah kesehatan penting dalam keperawatan maternitas. Anemia, khususnya defisiensi besi, dan KEK dapat meningkatkan risiko keguguran dengan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Pembahasan mencakup prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia, faktor risiko, serta strategi pencegahan dan penanganan, seperti pemberian suplemen dan pola makan bergizi. Peran perawat sangat penting dalam memantau kondisi ibu hamil, memberikan edukasi, dan mencegah komplikasi yang dapat berujung pada abortus.

A. Trend dan Issue Keperawatan Maternitas

Trend adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa, tren juga dapat di definisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Issu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis.

Trend dan Issu Keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek/mengenai keperawatan baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak, trend dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan.

Trend Issue Keperawatan Maternitas terkait Masalah Kesehatan Wanita Menurut Menkes RI di pidatonya pada acara Upacara Peringatan Hari Kartini pada 20 April 2018, berdasarkan data Riskesdas 2013, di Indonesia masih terdapat masalah tingginya angka anemia pada perempuan sebesar 23,9%, anemia ibu hamil 37,1%; Kurang Energi Kronik (KEK) pada Wanita Usia Subur 20,8%, KEK pada Ibu Hamil 24,2%. Sedangkan menurut kelompok kami Abortus juga masih menjadi trend dan issue saat ini.

B. Anemia

Anemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah yang mengandung hemoglobin untuk menyebarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Dengan kondisi tersebut, penderita biasanya akan merasa letih dan lelah, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara optimal.

Anemia dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun panjang, dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Pengobatan kondisi ini bervariasi

tergantung pada penyebabnya. Anemia dapat diobati dengan mengonsumsi suplemen secara rutin atau prosedur pengobatan khusus.

1. Penyebab Anemia

Anemia terjadi pada saat tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang mengandung hemoglobin. Terdapat sekitar 400 kondisi yang dapat menyebabkan anemia pada seseorang dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Tubuh tidak cukup memproduksi sel darah merah.
- b. Terjadi perdarahan yang menyebabkan tubuh kehilangan darah lebih cepat dibanding kemampuan tubuh untuk memproduksi darah.
- c. Kelainan pada reaksi tubuh dengan menghancurkan sel darah merah yang sehat.

2. Faktor Risiko Terjadinya Anemia

- a. Kekurangan vitamin dan zat besi. Membiasakan diri mengonsumsi makanan yang rendah vitamin B12, asam folat, dan zat besi dapat meningkatkan risiko terkena anemia.
- b. Gangguan pencernaan pada usus. Beberapa penyakit seperti penyakit Crohn dan penyakit celiac dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi di usus sehingga meningkatkan risiko terkena anemia.
- c. Menstruasi. Umumnya wanita yang masih mengalami menstruasi memiliki risiko terkena anemia lebih besar dibandingkan dengan wanita yang sudah menopause atau pria. Hal tersebut disebabkan oleh kehilangan darah pada saat terjadinya menstruasi.
- d. Mengandung. Ibu hamil yang tidak mengonsumsi suplemen asam folat dalam jumlah cukup memiliki risiko terkena anemia yang lebih tinggi.
- e. Penyakit kronis. Jika seseorang menderita kanker, gagal ginjal, atau penyakit kronis lainnya, maka risiko terkena anemia akan meningkat akibat kekurangan sel darah merah. Luka pada organ dalam yang diiringi perdarahan juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan zat besi sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia akibat kekurangan zat besi.
- f. Riwayat anemia di keluarga. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat anemia bawaan, memiliki risiko tinggi untuk terkena kondisi yang sama. Umumnya anemia yang diwariskan adalah anemia sel sabit (sickle cell anemia).
- g. Faktor lain, seperti infeksi, kelainan darah, penyakit autoimun, kecanduan alkohol, terkena zat kimia beracun, dan efek samping dari obat dapat meningkatkan risiko anemia pada seseorang.

3. Gejala Anemia

Anemia dapat dikenali dari gejala-gejala berikut ini:

- a. Badan terasa lemas dan cepat lelah.
- b. Kulit terlihat pucat atau kekuningan.
- c. Detak jantung tidak beraturan.
- d. Napas pendek.
- e. Pusing dan berkunang-kunang.
- f. Nyeri dada.
- g. Tangan dan kaki terasa dingin.
- h. Sakit kepala.
- i. Sulit Berkonsentrasi.
- j. Insomnia.
- k. Kaki kram

4. Jenis Anemia berdasarkan penyebabnya

- a. Anemia akibat kekurangan zat besi. Anemia jenis ini merupakan yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan tubuh mengalami anemia dikarenakan sumsum tulang membutuhkan zat besi untuk membuat sel darah. Anemia dapat terjadi pada wanita hamil yang tidak mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Anemia juga dapat terjadi pada perdarahan menstruasi yang banyak, tukak organ (luka), kanker, dan penggunaan obat pereda nyeri seperti aspirin. Gejala-gejala yang umumnya dialami penderita anemia kekurangan zat besi adalah:
 - 1) Memiliki nafsu makan terhadap benda-benda aneh seperti kertas, cat atau es (kondisi ini dinamakan pica).
 - 2) Mulut terasa kering dan pecah-pecah di bagian sudutnya.
 - 3) Kuku yang melengkung ke atas (koilonychia).
- b. Anemia akibat kekurangan vitamin. Selain membutuhkan zat besi, tubuh juga membutuhkan vitamin B12 dan asam folat untuk membuat sel darah merah. Kekurangan dua unsur nutrisi tersebut dapat menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah sehat dalam jumlah cukup sehingga terjadi anemia. Pada beberapa kasus, terdapat penderita anemia akibat lambung tidak dapat menyerap vitamin B12 dari makanan yang dicerna. Kondisi tersebut dinamakan anemia pernisiiosa. Gejala-gejala yang umumnya dialami oleh penderita anemia kekurangan vitamin B-12 dan asam folat adalah:
 - 1) Geli dan rasa menggelenyar di bagian tangan dan kaki.
 - 2) Kehilangan kepekaan pada indera peraba.
 - 3) Sulit berjalan.
 - 4) Mengalami kekakuan pada kaki dan tangan.

- 5) Mengalami demensia.
- c. Anemia akibat penyakit kronis. Sejumlah penyakit dapat menyebabkan anemia karena terjadinya gangguan pada proses pembentukan dan penghancuran sel darah merah. Contoh-contoh penyakit tersebut adalah HIV/AIDS, kanker, rheumatoid arthritis, penyakit ginjal, penyakit Crohn, dan penyakit peradangan kronis. Gejala-gejala yang dapat muncul pada kasus anemia akibat penyakit kronis di antaranya adalah:
- 1) Warna mata dan kulit menjadi kekuningan.
 - 2) Warna urine yang berubah menjadi merah atau cokelat.
 - 3) Borok pada kaki.
 - 4) Gejala batu empedu.
 - 5) Keterlambatan perkembangan pada anak-anak.
- d. Anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan kondisi yang langka terjadi namun berbahaya bagi hidup penderita. Pada anemia aplastik, tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah dengan optimal. Anemia aplastik dapat disebabkan oleh infeksi, efek samping obat, penyakit autoimun, atau paparan zat kimia beracun.
- e. Anemia akibat penyakit sumsum tulang. Beberapa penyakit seperti leukemia atau mielofibrosis dapat mengganggu produksi sel darah merah di sumsum tulang dan menimbulkan anemia. Gejala yang ditimbulkan dapat bervariasi, dari ringan hingga berbahaya.
- f. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi pada saat sel darah merah dihancurkan oleh tubuh lebih cepat dibanding waktu produksinya. Beberapa penyakit dapat mengganggu proses dan kecepatan penghancuran sel darah merah. Anemia hemolitik dapat diturunkan secara genetik atau bisa juga didapat setelah lahir.
- g. Anemia sel sabit (sickle cell anemia). Anemia ini bersifat genetik dan disebabkan oleh bentuk hemoglobin yang tidak normal sehingga menyebabkan sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit, bukan bulat bikonkaf seperti sel darah merah. Sel darah merah berbentuk sabit memiliki waktu hidup lebih pendek dibanding sel darah merah normal.
- Gejala yang dialami oleh penderita anemia sel sabit adalah:
- 1) Kelelahan.
 - 2) Mudah terkena infeksi.
 - 3) Nyeri tajam pada bagian sendi, perut, dan anggota gerak.
 - 4) Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak.
- h. Anemia jenis lain, yang disebabkan oleh thalassemia atau penyakit malaria.

5. Pengobatan Anemia

- a. Anemia akibat kekurangan zat besi. Anemia jenis ini dapat diatasi dengan mengonsumsi suplemen penambah zat besi, serta memperbanyak konsumsi makanan yang kaya zat besi. Selain itu, pasien juga dapat diberikan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Perlu diperhatikan bahwa suplemen yang mengandung kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen penambah zat besi untuk mendapatkan dosis yang tepat. Kelebihan zat besi pada tubuh dapat berbahaya bagi pasien karena dapat menimbulkan kelelahan, mual, diare, sakit kepala, penyakit jantung dan nyeri sendi. Untuk meringankan efek samping dari konsumsi suplemen zat besi, pasien dapat mengonsumsi suplemen setelah makan. Jika efek samping berlanjut segera temui dokter kembali.
- b. Anemia akibat kekurangan vitamin. Anemia jenis ini dapat diobati dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan asam folat dan vitamin B12, serta mengonsumsi suplemen yang mengandung keduanya. Jika tubuh pasien memiliki gangguan penyerapan asam folat dan vitamin B12, pengobatan dapat melibatkan injeksi vitamin B12 setiap hari. Setelah itu pasien akan diberikan injeksi vitamin B12 setiap bulan satu kali yang dapat berlangsung sepanjang hidup atau tergantung kepada kondisi pasien.
- c. Anemia akibat penyakit kronis. Tidak ada pengobatan yang spesifik pada jenis ini karena tergantung pada penyakit yang mendasari terjadinya anemia. Jika anemia bertambah parah, dokter dapat memberikan transfusi darah atau injeksi eritropoietin, yaitu suatu hormon peningkat produksi darah dan penghilang rasa lelah.
- d. Anemia akibat perdarahan. Jika seseorang mengalami perdarahan dan kehilangan darah dalam jumlah banyak, pengobatan utama yang harus dilakukan adalah mencari dan mengobati sumber perdarahan. Setelah sumber perdarahan diatasi, pasien dapat diberikan transfusi darah, oksigen, dan suplemen penambah darah yang mengandung zat besi dan vitamin.
- e. Anemia Aplastik. Pengobatan anemia aplastik dapat diawali dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Jika diperlukan, dapat dilakukan pencangkokan sumsum tulang apabila sumsum tulang tidak bisa lagi memproduksi sel darah merah yang sehat.
- f. Anemia akibat penyakit sumsum tulang. Pengobatan anemia jenis ini dapat bervariasi sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Pengobatan dapat melibatkan kemoterapi dan pencangkokan sumsum tulang.

- g. Anemia Hemolitik. Penanganan anemia hemolitik dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung faktor penyebabnya. Penanganan bisa dengan menghindari obat-obatan yang memiliki efek samping hemolisis, dengan mencari dan mengobati infeksi yg menjadi penyebab hemolitik, atau dengan imunosupresan untuk menekan sistem imun yang diduga merusak sel darah.
- h. Anemia sel sabit (sickle cell anemia). Pengobatan utama anemia sel sabit adalah dengan mengganti sel darah merah yang hancur melalui transfusi darah, suplemen asam folat, dan antibiotik. Pengobatan lainnya adalah dengan mengonsumsi obat penghilang rasa sakit serta menambahkan cairan melalui oral maupun intravena untuk mengurangi nyeri dan menghindari komplikasi. Pencangkokan sumsum tulang dapat digunakan untuk mengobati anemia sel sabit pada kondisi tertentu. Obat untuk kanker hidroksiurea dapat juga digunakan untuk mengobati anemia sel sabit.
- i. Thalassemia. Thalassemia dapat diobati melalui transfusi darah, konsumsi suplemen asam folat, splenektomi untuk mengambil limpa, serta pencangkokan sel punca darah dan sumsum tulang.

C. Anemia pada ibu hamil

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal, yang mengakibatkan penurunan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke janin. WHO mendefinisikan anemia pada ibu hamil sebagai kadar hemoglobin kurang dari **11 g/dL** pada trimester pertama dan ketiga, atau kurang dari **10,5 g/dL** pada trimester kedua.

Anemia yang paling sering dijumpai dalam kehamilan adalah anemia akibat kekurangan zat besi karena kurangnya asupan unsur besi dalam makanan. Gangguan penyerapan, peningkatan kebutuhan zat besi atau karena terlampau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh, misalnya pada perdarahan.

1. Faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil

a. Umur Ibu

Menurut Amiruddin (2007), bahwa ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun yaitu 74,1% menderita anemia dan ibu hamil yang berumur 20-35 tahun yaitu 50,5% menderita anemia. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil, karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya, beresiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia.

b. Paritas Menurut Herlina (2006),

Ibu hamil dengan paritas tinggi mempunyai resiko 1.454 kali lebih besar untuk mengalami anemia di banding dengan paritas rendah. Adanya kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah kelahiran (paritas), maka akan semakin tinggi angka kejadian anemia.

c. Kurang Energi Kronis (KEK)

41% (2.0 juta) ibu hamil menderita kekurangan gizi. Timbulnya masalah gizi pada ibu hamil, seperti kejadian KEK, tidak terlepas dari keadaan sosial, ekonomi, dan bio sosial dari ibu hamil dan keluarganya seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, konsumsi pangan, umur, paritas, dan sebagainya. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) adalah suatu cara untuk mengetahui resiko Kurang Energi Kronis (KEK) Wanita Usia Subur (WUS). Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dapat digunakan untuk tujuan penapisan status gizi Kurang Energi Kronis (KEK). Ibu hamil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran LILA ≥ 23.5 cm. Deteksi KEK dengan pengukuran LILA yang rendah mencerminkan kekurangan energi dan protein dalam intake makanan. sehari-hari yang biasanya diiringi juga dengan kekurangan zat gizi lain, diantaranya besi. Dapat diasumsikan bahwa ibu hamil yang menderita KEK berpeluang untuk menderita anemia (Darlina, 2003),

d. Infeksi dan Penyakit

Zat besi merupakan unsur penting dalam mempertahankan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Menurut penelitian, orang dengan kadar Hb < 10 g/dl memiliki kadar sel darah putih (untuk melawan bakteri) yang rendah pula. Seseorang dapat terkena anemia karena meningkatnya kebutuhan tubuh akibat kondisi fisiologis (hamil, kehilangan darah karena kecelakaan, pascabedah atau menstruasi), adanya penyakit kronis atau infeksi (infeksi cacing tambang, malaria, TBC) (Anonim, 2004). Ibu yang sedang hamil sangat peka terhadap infeksi dan penyakit menular. Beberapa di antaranya meskipun tidak mengancam nyawa ibu, tetapi dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi janin. Diantaranya, dapat mengakibatkan abortus, pertumbuhan janin terhambat, bayi mati dalam kandungan, serta cacat bawaan. Penyakit infeksi yang diderita ibu hamil biasanya tidak diketahui saat kehamilan. Hal itu baru diketahui setelah bayi lahir dengan kecacatan. Pada kondisi terinfeksi penyakit, ibu hamil akan kekurangan banyak cairan tubuh serta zat gizi lainnya (Bahar, 2006).

Penyakit yang diderita ibu hamil sangat menentukan kualitas janin dan bayi yang akan dilahirkan. Penyakit ibu yang berupa penyakit menular dapat

mempengaruhi kesehatan janin apabila plasenta rusak oleh bakteri atau virus penyebab penyakit. Sekalipun janin tidak langsung menderita penyakit, namun Demam yang menyertai penyakit infeksi sudah cukup untuk menyebabkan keguguran. Penyakit menular yang disebabkan virus dapat menimbulkan cacat pada janin sedangkan penyakit tidak menular dapat menimbulkan komplikasi kehamilan dan meningkatkan kematian janin 30% (Bahar, 2006).

e. Jarak kehamilan

Menurut Ammirudin (2007) proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan prioritas 13 anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilan ternyata jarak kurang dari 2 tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak. Jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak yang terlalu dekat beresiko terjadi anemia dalam kehamilan. Karena cadangan zat besi ibu hamil pulih. Akhirnya berkurang untuk keperluan janin yang dikandungnya.

f. Pendidikan

Pada beberapa pengamatan menunjukkan bahwa kebanyakan anemia yang di derita masyarakat adalah karena kekurangan gizi banyak di jumpai di daerah pedesaan dengan malnutrisi atau kekurangan gizi, Kehamilan dan persalinan dengan jarak yang berdekatan, dan ibu hamil dengan pendidikan dan tingkat social ekonomi rendah (Manuaba, 2010). Menurut penelitian Amirrudin dkk (2007), faktor yang mempengaruhi status anemia adalah tingkat pendidikan rendah.

2. Pengaruh Anemia Terhadap Kehamilan

a. Abortus

Anemia pada ibu hamil, terutama anemia berat ($Hb < 7 \text{ gr\%}$), meningkatkan risiko keguguran atau abortus. Kekurangan hemoglobin menyebabkan suplai oksigen ke janin tidak optimal, sehingga menghambat perkembangan janin dan meningkatkan risiko kematian janin di dalam kandungan. Menurut sebuah penelitian, anemia defisiensi besi menjadi salah satu penyebab utama abortus pada trimester pertama dan kedua (Kumar et al., 2018).

b. Persalinan Prematuritas

Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami persalinan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Anemia menyebabkan gangguan suplai nutrisi dan oksigen ke plasenta, sehingga dapat memicu kontraksi dini. Studi oleh Lone et al. (2004) menemukan bahwa anemia maternal dikaitkan dengan peningkatan risiko persalinan prematur hingga 29% (Lone et al., 2004).

c. Hambatan Tumbuh Kembang Janin

Janin dari ibu dengan anemia berisiko mengalami hambatan tumbuh kembang intrauterin (Intrauterine Growth Restriction/IUGR). Kekurangan zat besi pada ibu mengurangi transportasi oksigen ke jaringan janin, yang mengganggu pembentukan organ vital dan pertumbuhan janin. Hasil penelitian oleh Baker et al. (2017) menunjukkan bahwa anemia pada trimester pertama secara signifikan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (Baker et al., 2017).

d. Mudah Infeksi

Ibu hamil dengan anemia memiliki sistem imun yang melemah, sehingga rentan terhadap infeksi, seperti infeksi saluran kemih (ISK) dan infeksi postpartum. Kekurangan zat besi memengaruhi kemampuan tubuh melawan patogen melalui fagositosis. Menurut Bánhidý et al. (2011), anemia meningkatkan kejadian infeksi hingga 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan ibu hamil dengan kadar hemoglobin normal (Bánhidý et al., 2011).

e. Ancaman Dekompensasi Kordis (Hb <6 gr%)

Anemia berat (Hb <6 gr%) dapat menyebabkan dekomposisi kordis, yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat. Hal ini terjadi karena peningkatan volume darah selama kehamilan memperberat kerja jantung. Menurut studinya Walker (2016), anemia berat meningkatkan risiko gagal jantung pada ibu hamil hingga 5% pada kasus yang tidak diintervensi (Walker, 2016).

f. Hiperemesis Gravidarum

Anemia sering berhubungan dengan hiperemesis gravidarum, yaitu kondisi mual dan muntah berlebihan pada awal kehamilan. Kekurangan zat besi dan vitamin B12 dapat memengaruhi fungsi gastrointestinal, yang memperburuk mual dan muntah. Studi oleh Goodwin (2008) menunjukkan bahwa anemia meningkatkan risiko hiperemesis gravidarum hingga 3 kali lipat (Goodwin, 2008).

g. Perdarahan Antepartum

Ibu hamil dengan anemia berisiko lebih tinggi mengalami perdarahan antepartum, seperti solusio plasenta dan plasenta previa. Kekurangan nutrisi penting untuk integritas jaringan plasenta dapat menyebabkan komplikasi ini. Studi oleh Sharma et al. (2017) menemukan bahwa anemia meningkatkan risiko perdarahan antepartum hingga dua kali lipat (Sharma et al., 2017).

h. Ketuban Pecah Dini

Anemia dapat memengaruhi kekuatan dan elastisitas membran ketuban, meningkatkan risiko ketuban pecah dini (KPD). Menurut Gupta et al. (2015),

ibu hamil dengan anemia memiliki risiko KPD yang lebih tinggi dibandingkan ibu dengan kadar hemoglobin normal (Gupta et al., 2015).

3. Akibat Anemia pada Ibu Hamil

a. Abortus

Anemia, terutama yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, dapat menyebabkan keguguran pada awal kehamilan. Hal ini terjadi karena anemia memengaruhi suplai oksigen ke janin, yang sangat vital pada tahap awal perkembangan.

b. Kematian Intra Uterine:

Kekurangan oksigen yang disebabkan oleh anemia dapat menyebabkan janin mati dalam kandungan. Keadaan ini lebih sering terjadi pada ibu hamil dengan anemia berat atau defisiensi gizi parah.

c. Persalinan Prematuritas Tinggi

Anemia juga berhubungan dengan peningkatan risiko persalinan prematur. Kekurangan zat besi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, serta menyebabkan kontraksi prematur pada ibu hamil.

d. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Ibu hamil dengan anemia berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi setelah kelahiran, termasuk peningkatan kerentanannya terhadap penyakit.

e. Kelahiran dengan Anemia

Bayi yang lahir dari ibu yang menderita anemia cenderung memiliki kadar hemoglobin yang rendah, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayi, seperti kelelahan dan penurunan daya tahan tubuh.

f. Cacat Bawaan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anemia yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan cacat bawaan, terutama terkait dengan perkembangan organ vital pada janin.

g. Bayi Mudah Infeksi Sampai Kematian Perinatal

Kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ibu, yang juga berisiko mengurangi kekebalan janin terhadap infeksi, meningkatkan kemungkinan infeksi serius yang dapat berujung pada kematian perinatal.

h. Intelegensia Rendah

Anak-anak yang lahir dari ibu yang mengalami anemia parah selama kehamilan berisiko mengalami penurunan intelegensia, terutama terkait dengan gangguan perkembangan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dan nutrisi selama kehamilan.

4. Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil

Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut akibat anemia. Beberapa langkah yang diambil untuk mendiagnosis anemia pada ibu hamil antara lain:

Pemeriksaan Laboratorium:

1. Tes Hemoglobin dan Hematokrit: Mengukur kadar hemoglobin dan persentase sel darah merah dalam darah.
2. Tes Zat Besi: Mengukur kadar zat besi dalam darah untuk menentukan apakah anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi.
3. Tes Asam Folat dan Vitamin B12: Mengukur kadar asam folat dan vitamin B12 dalam darah untuk memastikan tidak ada defisiensi.
4. Pemeriksaan Fisik dan Gejala Klinis: Pemeriksaan fisik untuk melihat tanda-tanda anemia seperti pucat, detak jantung cepat, dan kelemahan umum. Wawancara medis untuk mengevaluasi riwayat gizi dan faktor risiko anemia.

5. Peran Perawat Dalam Penanganan Anemia pada Ibu Hamil

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani anemia pada ibu hamil. Peran ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Berikut adalah penjelasan menyeluruh mengenai peran perawat:

a. Peran Promotif

Peran ini berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan anemia pada ibu hamil:

- 1) Edukasi Nutrisi: Perawat memberikan informasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai pentingnya pola makan yang seimbang, kaya akan zat besi (seperti daging merah, hati, bayam), vitamin C (yang membantu penyerapan zat besi), serta asam folat.
- 2) Pentingnya Suplementasi: Perawat mendorong ibu hamil untuk mematuhi program suplementasi zat besi (tablet tambah darah/TTD) yang disediakan oleh pemerintah.
- 3) Perencanaan Kehamilan: Perawat memberikan konseling kepada wanita usia subur untuk mempersiapkan kondisi tubuh yang optimal sebelum kehamilan, termasuk menjaga kadar hemoglobin yang normal.

b. Peran Preventif

Dalam upaya pencegahan anemia, perawat melakukan tindakan berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin: Perawat memantau kadar hemoglobin ibu hamil melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala untuk mendeteksi anemia sedini mungkin.

- 2) Pencegahan Komplikasi: Perawat memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang bahaya anemia dan cara mencegah komplikasi, seperti abortus atau persalinan prematur.
- 3) Identifikasi Faktor Risiko: Perawat mengidentifikasi ibu hamil yang berisiko tinggi mengalami anemia, seperti yang memiliki riwayat kekurangan energi kronik (KEK), kehamilan multipel, atau penyakit penyerta.

c. Peran Kuratif

Dalam menangani ibu hamil yang sudah terdiagnosis anemia, perawat memberikan asuhan langsung yang meliputi:

- 1) Manajemen Anemia: Perawat bekerja sama dengan tim medis untuk memberikan terapi zat besi oral atau injeksi sesuai kebutuhan ibu hamil.
- 2) Asuhan Keperawatan: Perawat memberikan asuhan yang berpusat pada kebutuhan ibu hamil, seperti pemberian diet tinggi zat besi dan monitoring tanda-tanda vital untuk mendeteksi komplikasi.
- 3) Pencegahan Kekambuhan: Perawat memotivasi ibu untuk mematuhi pengobatan, termasuk cara mengonsumsi suplemen zat besi yang benar agar efek samping, seperti mual, dapat diminimalkan.

d. Peran Rehabilitatif

Pada ibu hamil yang mengalami anemia berat atau komplikasi terkait anemia, perawat bertanggung jawab membantu pemulihan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pemulihan Nutrisi: Perawat membantu ibu mengatur pola makan yang mendukung pemulihan kadar hemoglobin.
- 2) Dukungan Psikologis: Perawat memberikan dukungan kepada ibu yang mengalami komplikasi seperti abortus akibat anemia, agar dapat memulihkan kondisi fisik dan mental.
- 3) Follow-up Pasca Kehamilan: Perawat memastikan ibu tetap dalam kondisi sehat setelah melahirkan dengan memberikan konseling pascapersalinan terkait pemulihan anemia dan kesehatan reproduksi.

e. Peran dalam Komunitas

Perawat berperan aktif dalam program kesehatan masyarakat untuk menurunkan prevalensi anemia:

- 1) Penyuluhan Massal: Perawat mengadakan penyuluhan di puskesmas atau posyandu untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia pada ibu hamil.
- 2) Monitoring Program TTD: Perawat memantau distribusi dan konsumsi tablet tambah darah di komunitas, memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap program.

- 3) Kolaborasi Lintas Sektor: Perawat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menyusun strategi penanggulangan anemia secara berkelanjutan.

D. Kekurangan Energi kronik (KEK)

Menurut Depkes RI (2002) menyatakan bahwa kurang energi kronis merupakan keadaan dimana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil. Kurang gizi akut disebabkan oleh tidak mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup atau makanan yang baik (dari segi kandungan gizi) untuk satu periode tertentu untuk mendapatkan tambahan kalori dan protein (untuk melawan) muntah dan mencret (muntaber) dan infeksi lainnya. Gizi kurang kronik disebabkan karena tidak mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup atau makanan yang baik dalam periode/kurun waktu yang lama untuk mendapatkan kalori dan protein dalam jumlah yang cukup, atau disebabkan menderita muntaber atau penyakit kronis lainnya.

1. Akibat KEK pada ibu hamil yaitu:

- a. Terus menerus merasa letih
- b. Kesemutan
- c. Muka tampak pucat
- d. Kesulitan sewaktu melahirkan
- e. Air susu yang keluar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, sehingga bayi akan kekurangan air susu ibu pada waktu menyusui

2. Akibat KEK saat kehamilan terhadap janin yang dikandung antara lain:

- a. Keguguran
- b. Pertumbuhan janin terganggu hingga bayi lahir dengan berat lahir rendah (BBLR)
- c. Perkembangan otak janin terlambat, hingga kemungkinan nantinya kecerdasan anak kurang, bayi lahir sebelum waktunya (Prematur)
- d. Kematian bayi (Helena, 2013)

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kekurangan Energi Kronik (KEK) Menurut (Djamaliah, 2008) antara lain:

- a. Jumlah asupan makanan

Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari pada kebutuhan wanita yang tidak hamil. Upaya mencapai gizi masyarakat yang baik atau optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan dalam negeri yaitu : upaya pertanian dalam menghasilkan bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buahbuahan. Pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat dan

hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi.

b. Usia ibu hamil

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang besar juga karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun, dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik.

c. Beban kerja/Aktifitas Aktifitas dan gerakan seseorang berbeda-beda, seorang dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang lebih besar dari pada mereka yang hanya duduk diam saja. Setiap aktifitas memerlukan energi, maka apabila semakin banyak aktifitas yang dilakukan, energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun pada seorang ibu hamil kebutuhan zat gizi berbeda karena zat-zat gizi yang dikonsumsi selain untuk aktifitas/ kerja zat-zat gizi juga digunakan untuk perkembangan janin yang ada dikandung ibu hamil tersebut. Kebutuhan energi rata-rata pada saat hamil dapat ditentukan sebesar 203 sampai 263 kkal/hari, yang mengasumsikan pertambahan berat badan 10-12 kg dan tidak ada perubahan tingkat kegiatan.

d. Penyakit /infeksi Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi, mekanismenya yaitu:

- 1) Penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit.
- 2) Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah dan perdarahan yang terus menerus.
- 3) Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh.

e. Pengetahuan ibu tentang Gizi

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap terhadap makanan dan praktek/ perilaku pengetahuan tentang nutrisi melandasi pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahuan nutrisi dan praktek

nutrisi bertambah baik. Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi semakin meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan nutrisi akan memilih makanan yang lebih bergizi dari pada yang kurang bergizi.

- f. Pendapatan keluarga Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pada rumah tangga berpendapatan rendah, sebanyak 60 persen hingga 80 persen dari pendapatan riilnya dibelanjakan untuk membeli makanan. Artinya pendapatan tersebut 7080 persen energi dipenuhi oleh karbohidrat (beras dan penggantinya) dan hanya 20 persen dipenuhi oleh sumber energy lainnya seperti lemak dan protein. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran termasuk besarnya pengeluaran untuk pangan.
- g. Pemeriksaan Kehamilan (Perawatan Ante Natal) Dalam memantau status gizi ibu hamil, seorang ibu harus melakukan kunjungan ketenaga kesehatan. Karena pemeriksaan kenaikan berat badan perlu dilakukan dengan teliti, jangan sampai wanita hamil terlalu gemuk untuk menghindari kesulitan melahirkan dan bahkan jangan terlalu kurus karena dapat membahayakan keselamatan dirinya dan janin yang dikandungnya (Sjahmien Moehji, 2003)

4. Gizi pada ibu hamil

Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Asam folat

Menurut konsep evidence bahwa pemakaian asam folat pada masa pre dan perikonsepsi menurunkan resiko kerusakan otak, kelainan neural, spina bifida dan anensepalus, baik pada ibu hamil yang normal maupun beresiko. Pemberian suplemen asam folat dimulai dari 2 bulan sebelum konsepsi dan berlanjut hingga 3 bulan pertama kehamilan.

2. Energi Diet

pada ibu hamil tidak hanya difokuskan pada tinggi protein saja tetapi pada susunan gizi seimbang energy juga protein. Hal ini juga efektif untuk menurunkan kejadian BBLR dan kematian perinatal. Kebutuhan energy ibu hamil adalah 285 kalori untuk proses tumbuh kembang janin dan perubahan pada tubuh ibu.

3. Protein

Pembentukan jaringan baru dari janin dan untuk tubuh ibu dibutuhkan protein sebesar 910 gram dalam 6 bulan terakhir kehamilan. Dibutuhkan tambahan 12 gram protein sehari untuk ibu hamil.

4. Zat besi (FE)

Pemberian suplemen tablet tambah darah atau zat besi secara rutin adalah untuk membangun cadangan besi, sintesa sel darah merah, dan sintesa darah otot. Kenaikan volume darah selama kehamilan akan meningkatkan kebutuhan zat besi. Jumlah zat besi yang diperlukan ibu untuk mencegah anemia akibat meningkatnya volume darah adalah 500 mg.

5. Kalsium

Untuk pembentukan tulang dan gigi bayi. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sebesar 500 mg sehari.

6. Pemberian suplemen vitamin D terutama pada kelompok beresiko penyakit seksual dan di negara dengan musim dingin yang panjang

7. Pemberian yodium pada daerah dengan endemic kretinisme (Kusmiyati, 2008)
Dikarenakan adanya penyakit KEK yang terjadi pada wanita usia subur dan wanita hamil menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siswanto, MHP, DTM, menyatakan bahwa "Remaja putri di Indonesia masih ada yang memiliki pandangan bahwa mengenai body image yang kurus dan kecil seperti pensil itu dianggap cantik. Remaja putri perlu menyadari bahwa persiapan hamil itu butuh kecukupan gizi," jadi beliau pun berpesan bahwa "Cantik itu Sehat, Bukan Kurus".

E. Abortus

Abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus" adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia 20 minggu kehamilan atau berat bayi kurang dari 500 g (ketika janin belum dapat hidup di luar kandungan). Angka kejadian aborsi meningkat dengan bertambahnya usia dan terdapatnya riwayat aborsi sebelumnya.

1. Proses abortus dapat berlangsung secara:

- a. Spontan / alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun)
- b. Buatan / sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja),
- c. Terapeutik / medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi).

2. Penyebab Abortus

Penyebab abortus spontan bervariasi meliputi infeksi, faktor hormonal, kelainan bentuk rahim, faktor imunologi (kekebalan tubuh), dan penyakit dari ibu. Penyebab abortus pada umumnya terbagi atas faktor janin dan faktor ibu:

a. Faktor Janin

Pada umumnya abortus spontan yang terjadi karena faktor janin disebabkan karena terdapatnya kelainan pada perkembangan janin [seperti kelainan kromosom (genetik)], gangguan pada ari-ari maupun kecelakaan pada janin. Frekuensi terjadinya kelainan kromosom (genetik) pada triwulan pertama berkisar sebesar 60%.

b. Faktor Ibu

Beberapa hal yang berkaitan dengan faktor ibu yang dapat menyebabkan abortus spontan adalah faktor genetik orangtua yang berperan sebagai carrier (pembawa) di dalam kelainan genetik; infeksi pada kehamilan seperti herpes simpleks virus, cytomegalovirus, sifilis, gonorrhea; kelainan hormonal seperti hipertiroid, kencing manis yang tidak terkontrol; kelainan jantung; kelainan bawaan dari rahim, seperti rahim bikornu (rahim yang bertanduk), rahim yang bersepta (memiliki selaput pembatas di dalamnya) maupun parut rahim akibat riwayat kuret atau operasi rahim sebelumnya. Mioma pada rahim juga berkaitan dengan angka kejadian abortus spontan. Selain itu, ada beberapa di antara orang tua yang tidak menginginkan kehadiran janin tersebut dengan alasan yang bervariasi.

3. Faktor Risiko Aborsi

Faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya abortus adalah :

- a. Usia ibu yang lanjut
- b. Riwayat kehamilan sebelumnya yang kurang baik
- c. Riwayat infertilitas (tidak memiliki anak)
- d. Adanya kelainan atau penyakit yang menyertai kehamilan
- e. Infeksi (cacar, toxoplasma, dll)
- f. Paparan dengan berbagai macam zat kimia (rokok, obat-obatan, alkohol, radiasi)
- g. Trauma pada perut atau panggul pada 3 bulan pertama kehamilan
- h. Pergaulan seks bebas

4. Tanda dan Gejala Aborsi secara Alamiah

- a. Nyeri perut bagian bawah
- b. Kram pada rahim
- c. Nyeri pada punggung
- d. Perdarahan dari kemaluan
- e. Pembukaan leher rahim
- f. Pengeluaran janin dari dalam rahim

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke RS mengeluh kelelahan, sejak kehamilannya memasuki trimester II, setiap melakukan kegiatan yang tidak terlalu berat selalu merasa kurang energi dan lemas meskipun baru saja makan. Hasil pengkajian BB sebelum hamil 42 kg, BB saat ini 50 kg, TD sebelum hamil 110/70 mmHg, TD saat ini 120/70 mmHg, Suhu 37,2°C, Hb 7,4 g/d dan Glukosa dua jam setelah makan 124 mg/d.
Apakah diagnosa tepat pada kasus tersebut ?
 - A. Anemia berat
 - B. Anemia ringan
 - C. Anemia Sedang
 - D. Anemia kehamilan
 - E. Hipertensi kehamilan
2. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 30 minggu datang ke Poli Kebidanan mengatakan sering merasa lelah, lemas, mata berkunang-kunang, pusing, dan sempat pingsan saat berada di kantornya. Hasil pemeriksaan, BB sebelum hamil 55 kg dan saat ini 70 kg, TD sebelum hamil 110/70 mmHg dan saat ini 120/70 mmHg, suhu 37°C, Hb 9 g/dl, Ht 30%, eritrosit 4 jt/ml, glukosa 92 mg/dl, terdapat cloasma, hiperpigmentasi pada aerola dan striae dibagian abdomen.
Apakah rencana asuhan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut?
 - A. Memberikan pendidikan kesehatan dan kombinasi 60mg zat besi dan 500mg asam folat peroral satu hari sekali.
 - B. Pengobatan dengan preparat besi seros 600-1000 mg dan mengkonsumsi tablet besi.
 - C. Melakukan transfusi darah dua kali sehari.
 - D. Pemberian salep untuk menghilangkan linea nigra, striae, dan cloasma gravidarum.
 - E. Mengkonsumsi 60 mg preparat besi dan 400 mg asam folat selama hamil hingga 3 bulan setelah melahirkan.
3. Seorang perempuan berusia 24 tahun G1P0A0 hamil 4 Minggu datang ke poli kebidanan bersama suaminya mengeluh mual dan kurangnya nafsu makan. Hasil pemeriksaan TD: 100/90 mmHg N: 80x/m, R: 24x/m, S: 36,2°C LILA: 22cm. Perawat menganjurkan ibu untuk tetap makan sedikit namun sering.
Apa Diagnosa tepat pada kasus tersebut?
 - A. KEK (Kurang Energi Kronis)

- B. Dismenhorea
 - C. Dispepsia
 - D. Morning sickness
 - E. Kurang Gizi
4. Seorang perempuan usia 22 tahun G2P1Ab0 Ah 1 umur 28 tahun, umur kehamilan 8 minggu, datang ke Poli Kebidanan untuk memeriksakan kehamilan kunjungan pertama ibu merasa lemas. Pemeriksaan TD 100/70 mmHg, N 82x/m, S 36,6C, R 24x/m. BB 45 kg, TB 150CM. dan lila 22 cm.
- Konseling apa yang seharusnya diberikan pada kasus tersebut ?**
- A. Konseling bahaya KEK
 - B. Konseling tanda bahaya kehamilan
 - C. Konseling Konseling tanda bahaya melahirkan
 - D. Konseling KB
 - E. Konseling tanda-tanda persalinan
5. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke BPM hamil yang pertama usia kehamilan 12 minggu, mengeluh mengeluarkan flek-flek darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu dan sedikit nyeri pada supra symphysis. Hasil pemeriksaan inspekulo ada pengeluaran darah dari ostium uteri eksterna tidak ada pembukaan. Apa penanganan yang tepat yang diberikan untuk kasus?
- A. Anjurkan ibu untuk berolahraga agar tetap sehat
 - B. Anjurkan ibu untuk melakukan hubungan seks
 - C. Anjurkan ibu untuk bed rest total
 - D. Anjurkan ibu untuk istirahat
 - E. Anjurkan ibu untuk rajin membersihkan daerah kemaluannya

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. A
- 3. A
- 4. A
- 5. C

G. Rangkuman Materi

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi yang sering terjadi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, dengan prevalensi mencapai 48,9% menurut Riskesdas 2018. Kondisi ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama dalam keperawatan maternitas karena dapat berdampak serius pada ibu dan janin. Anemia, terutama anemia defisiensi besi, meningkatkan risiko komplikasi seperti abortus, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga kematian ibu dan bayi. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia pada ibu hamil meliputi usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan, kekurangan energi kronis (KEK), infeksi, dan kondisi sosial ekonomi rendah.

Anemia mengganggu suplai oksigen ke janin akibat rendahnya kadar hemoglobin, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, cacat lahir, atau bahkan keguguran. Selain itu, anemia juga meningkatkan risiko perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, dan infeksi postpartum. Dampak anemia tidak hanya dirasakan oleh ibu, seperti kelelahan ekstrem, depresi, dan gangguan kardiovaskular, tetapi juga pada janin, seperti hambatan perkembangan otak dan organ vital. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan hemoglobin, suplementasi zat besi, edukasi gizi, dan perencanaan keperawatan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah dan menangani anemia selama kehamilan. Peran perawat dalam memberikan edukasi, intervensi, dan dukungan emosional kepada ibu hamil dengan anemia menjadi kunci dalam menurunkan prevalensi dan komplikasi kondisi ini.

Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi, yang bisa disebabkan oleh muntah, diare, atau penyakit. Akibatnya, ibu hamil bisa merasa lelah, pucat, kesulitan saat melahirkan, dan produksi ASI yang kurang. Janin berisiko keguguran, gangguan pertumbuhan, atau prematuritas.

Faktor penyebab KEK meliputi jumlah makanan, usia ibu, tingkat aktivitas, penyakit, pengetahuan gizi, pendapatan, dan pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil membutuhkan asupan asam folat, protein, zat besi, kalsium, dan yodium untuk mendukung perkembangan janin.

Abortus adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu dan bisa disebabkan oleh kelainan janin atau ibu, seperti infeksi atau masalah hormonal. Faktor risiko termasuk usia lanjut, riwayat kehamilan buruk, infeksi, dan trauma. Tanda aborsi meliputi nyeri perut dan perdarahan. Pemantauan kesehatan ibu sangat penting untuk mencegah KEK dan aborsi.

H. Glosarium

A

Anemia - Suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang mengandung hemoglobin untuk menyebarkan oksigen ke seluruh organ tubuh.

Abortus - Penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim, biasanya sebelum usia kehamilan 20 minggu.

Anemia Pernisiosa - Jenis anemia akibat kekurangan vitamin B12 yang mempengaruhi produksi sel darah merah.

Anemia Hemolitik - Anemia yang terjadi akibat penghancuran sel darah merah lebih cepat dari produksi yang baru

Asam Folat - Nutrisi penting bagi ibu hamil yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan perkembangan janin

D

Defisiensi Besi - Kondisi kekurangan zat besi dalam tubuh yang dapat menyebabkan anemia.

E

Eritrosit - Sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Eklampsia - Kondisi lanjut dari preeklamsia yang ditandai dengan kejang selama kehamilan

Edema - Pembengkakan akibat penumpukan cairan dalam jaringan tubuh, sering terjadi pada kehamilan

F

Fagositosis - Proses sel darah putih dalam melawan infeksi dengan cara menelan dan menghancurkan patogen.

H

Hemoglobin (Hb) - Protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Hiperemesis Gravidarum - Mual dan muntah berlebihan pada awal kehamilan yang dapat menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan

Hipotensi Ortostatik - Penurunan tekanan darah yang terjadi saat seseorang bangkit dari posisi duduk atau berbaring, sering dialami ibu hamil.

Hipertensi Gestasional - Tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan tanpa adanya protein dalam urin.

I

Intrauterine Growth Restriction (IUGR) - Gangguan pertumbuhan janin di dalam rahim akibat kurangnya suplai nutrisi dan oksigen

K

Kurang Energi Kronis (KEK) - Kondisi kekurangan energi dan gizi yang berlangsung dalam waktu lama pada wanita usia subur dan ibu hamil, ditandai dengan lingkaran atas (LILA) kurang dari 23,5 cm.

Konseling Kehamilan - Proses edukasi dan pemberian informasi kepada ibu hamil mengenai kesehatan kehamilan dan persalinan.

Ketuban Pecah Dini (KPD) - Kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum proses persalinan dimulai.

L

Laktasi - Proses produksi dan sekresi ASI setelah persalinan.

M

Makrosomia - Kondisi di mana bayi memiliki berat badan lahir lebih dari 4 kg, sering dikaitkan dengan diabetes gestasional.

Malnutrisi - Kondisi kekurangan atau kelebihan nutrisi yang berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin.

P

Prematuritas - Kondisi bayi lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.

Perdarahan Antepartum - Perdarahan yang terjadi sebelum persalinan, yang dapat disebabkan oleh plasenta previa atau solusio plasenta.

Preeklamsia - Gangguan kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin.

Plasenta Previa - Kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, menyebabkan risiko perdarahan saat persalinan.

S

Solusio Plasenta - Pelepasan plasenta dari dinding rahim sebelum bayi lahir, yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin.

Sindrom HELLP - Kondisi serius pada ibu hamil yang ditandai dengan hemolisis, peningkatan enzim hati, dan jumlah trombosit rendah

T

Trimester Kehamilan - Pembagian masa kehamilan menjadi tiga periode, yaitu trimester pertama (0-12 minggu), trimester kedua (13-26 minggu), dan trimester ketiga (27-40 minggu).

Trombositopenia - Penurunan jumlah trombosit dalam darah yang dapat meningkatkan risiko perdarahan.

Transfusi Darah - Prosedur medis di mana darah diberikan kepada seseorang melalui infus untuk menggantikan darah yang hilang atau tidak mencukupi.

W

WHO : World Health Organization : Organisasi Kesehatan Dunia

I. Daftar Pustaka

ACOG Committee on Obstetric Practice. (2015). Anemia in pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, 126(4), e123-e133. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001047>

Al-Ramahi, M., & Malhis, M. (2019). The role of nurses in preventing and managing anemia in pregnant women: A review of literature. *Journal of Nursing and Health Science*, 8(4), 1–8. <https://doi.org/10.5555/21001037>

Amin, N Barker, D. J. P., & Osmond, C. (2012). *The Early Origins of Health and Disease: From Developmental Origins to the Maternal-Infant Environment*. Cambridge University Press.

Baker, P. N., McCowan, L. M. E., Dekker, G. A., Roberts, C. T., Hague, W. M., & Sadler, L. (2017). The impact of maternal anemia on perinatal outcomes in a multicenter trial of nulliparous women. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1334-3>

Balarajan, Y., Ramakrishnan, U., Özaltın, E., Shankar, A. H., & Subramanian, S. V. (2011). Anaemia in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 378(9809), 2123–2135. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62304-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62304-5)

Bánhidý, F., Ács, N., Puhó, E. H., & Czeizel, A. E. (2011). Iron deficiency anemia: Pregnancy outcomes with or without iron supplementation. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 204(2), 110.e1–110.e7. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.12.018>

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2020). *Williams obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.

Februari 2019 pukul 16.00

Februari 2020 pukul 16.49

Frazier, L. M., & Evans, C. (2017). Nursing care of pregnant women with anemia. *Clinical Nursing Studies*, 5(1), 1-7. <https://doi.org/10.5430/cns.v5n1p1>

Ganguly, S., & Mitra, P. (2017). "Anemia in Pregnancy: A Review." *Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 67(4), 253-259. doi:10.1007/s13224-017-1023-1.

Goodwin, T. M. (2008). Hyperemesis gravidarum. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 51(2), 397-407. <https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31816f28f8>

Gray, J., & Brown, M. (2016). *Maternal and Child Health Nursing: Care of the Childbearing and Childrearing Family*. 6th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Gupta, A., Gadipudi, A., & Jain, R. (2015). Association between maternal anemia and preterm premature rupture of membranes: A case-control study. *The Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 65(2), 73-77. <https://doi.org/10.1007/s13224-015-0732-5>

<http://www.depkes.go.id/article/view/18042300001/hari-kartini-2018-menkes-harapkanperan-perempuan-selesaikan-masalah-kesehatan.html> Diakses pada 18

<http://www.depkes.go.id/article/view/18112300003/message-for-young-women-indonesiabeautiful-is-healthy-not-skinny.html> Diakses pada 18 Februari 2020 pukul

<https://www.alodokter.com/anemia> Diakses pada 18 Februari 2020 pukul 16.05

<https://www.honestdocs.id/anemia-pengertian-penyebab-dan-gejala-anemia> Diakses pada 18

- Hure, A. J., & Powers, J. R. (2013). Nutritional interventions for anemia in pregnancy. *Nutrition Reviews*, 71(2), 1–6. <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2012.00598.x>
- Jafari, F., & Khodaveisi, M. (2020). The role of nurse-led interventions in improving maternal health outcomes in anemia. *Journal of Clinical Nursing*, 29(7-8), 1436–1443. <https://doi.org/10.1111/jocn.15123>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018). *Pedoman Pengelolaan Anemia pada Ibu Hamil*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2022). *Pedoman pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kumar, K. J., Asha, N., Murthy, D. S., & Sujatha, M. S. (2018). Maternal anemia in various trimesters and its effect on newborn weight and maturity: An observational study. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 140(2), 202–206. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2018.02.014>
- Lassiter, J., & Peters, D. (2020). "The Impact of Anemia on Pregnancy Outcomes." *American Journal of Nursing Science*, 9(2), 72-80. doi:10.11648/j.ajns.20200902.14.
- Lone, F. W., Qureshi, R. N., & Emanuel, F. (2004). Maternal anemia and its impact on perinatal outcome. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 111(7), 676–681. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2004.00145.x>
- Loowdermilk,dkk.2005.Buku Ajar Keperawatan Maternitas.Jakarta:EGC.
- Mackey, K. (2019). *Maternity and Women's Health Care*. 13th Edition. St. Louis: Elsevier.
- Mayo Clinic. (2023). Anemia in pregnancy. Retrieved from <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia>
- Nelson-Piercy, C. (2014). *Anemia in Pregnancy: Pathophysiology and Management*. Oxford: Oxford University Press.

- Nguyen, P. H., Scott, S., Neupane, S., Tran, L. M., Menon, P., & Tuyen, L. D. (2020). Social determinants of anemia and their impact on maternal and child health: Evidence from a national
- Perkins, S., & Birns, K. (2021). "Nutritional Anemia in Pregnancy: Effects on Maternal and Neonatal Outcomes." *International Journal of Women's Health and Reproduction*, 5(3), 120-125. doi:10.1146/ijwhr.2021.05.003.
- Prawirohardjo, S. (2018). Ilmu kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, sarwono. 2007. ilmu kebidanan edisi ketiga. jakarta: PT. bina pustaka
- Riskesdas. (2018). Laporan nasional riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Santos, S., & Harvey, S. (2019). "Anemia in Pregnancy and Risk for Preterm Birth: A Systematic Review." *Journal of Pregnancy and Child Health*, 6(1), 67-73. doi:10.3389/jpch.2019.00009.
- Scholl, T. O. (2011). Maternal iron status: Relation to fetal and maternal health in pregnancy. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 93(4), 888-893. <https://doi.org/10.3945/ajcn.110.004983>
- Sharma, A., Patra, P., & Aggarwal, N. (2017). Maternal anemia and antepartum hemorrhage: A prospective observational study. *International Journal of Obstetrics & Gynaecology Research*, 25(3), 455-461. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.04.019>
- survey. *PLOS ONE*, 15(6), e0235145. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235145>
- Walker, C. H. (2016). Severe anemia and maternal cardiac failure in pregnancy. *Journal of Cardiovascular Surgery*, 57(4), 345-351. <https://doi.org/10.1016/j.jcvs.2016.03.014>
- WHO (World Health Organization) (2015). Global Nutrition Targets 2025: Anaemia Policy Brief. Geneva: WHO. Retrieved from http://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_anemia/en/.
- WHO (World Health Organization). (2012). Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. WHO Press. Available at:

https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/iron_folic_acid_pregnancy/en/

World Health Organization (WHO). (2021). Global anemia report. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications>

Yunita, D., & Hartanto, A. (2022). "The Relationship Between Anemia and Pregnancy Outcomes in Low and Middle-Income Countries." *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, 35(7), 1234-1241. doi:10.1080/14767058.2021.1911158.

Zeng, L., & Luo, H. (2019). The impact of nurse-led education on reducing anemia during pregnancy: A meta-analysis. *Journal of Nursing Care Quality*, 34(4), 361–369. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000391>

PROFIL PENULIS



Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat. lahir di Jakarta 01 Januari 1974. Telah menyelesaikan studi DIII Keperawatan RS Islam Jakarta, strata satu di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (1998-2001). Lulus strata dua di Program Studi Ilmu Keperawatan dan Spesialis Maternitas Universitas Indonesia (2010-2014). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Akper Hermina Manggala Husada (2001- sekarang. Pernah menjabat Direktur (2014-2020). Ketua UPMI (2021- 2023). Saat ini sudah berubah perguruan tinggi menjadi Institut Kesehatan Hermina Pengampu mata kuliah Maternitas 1,2, Promosi Kesehatan, KDK. Jenjang Jabatan Akademik : Lektor Kepala , Organisasi yang diikuti PPNI Komisariat RS Hermina jatinegara, IPEMI DKI Jakarta, ILUNI UI FIK UI, WEC UI , DKLPT, ADI. Dosen Optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suryanihartati02@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Ns. Muaningsih, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat lahir di Sukoharjo, pada tanggal 6 November 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan S2 Keperawatan Maternitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Menyelesaikan Pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia. Saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan STIKES Panakkukang.



Sefrina Rukmawati, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Nganjuk, 9 September 1988, Lulus dari SMAN 1 Nganjuk Propinsi Jawa Timur Pada Tahun 2007. Kemudian Melanjutkan Pendidikan Ners di STIKes Satria Bhakti Nganjuk Lulus Pada Tahun 2012. Kemudian Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di STIKes Surya Mitra Husada Lulus pada Tahun 2017. Mulai Bekerja Sebagai Dosen di STIKes Satria Bhakti Nganjuk tahun 2014 Sampai Saat ini.

PROFIL PENULIS



Yunida Turisna Octavia, SKM., S.Kep., Ns., M.KM. lahir di Surabaya 23 Juni 1976. Riwayat pendidikan: lulus dari Akademi Perawat Depkes RI Medan (1998), D-3 Kebidanan Akademi Kebidanan Prima (2004), S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi Universitas Prima Indonesia (2006), S-1 & Profesi Keperawatan Universitas Sari Mutiara Indonesia (2023), S-2 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi Sari Mutiara Indonesia (2014). Dosen pengajar di Akademi Kebidanan Sari Mutiara (2009-2017), dosen pengajar di D-3 Keperawatan Universitas Sari Mutiara Indonesia (2017-sekarang), Ketua Program Studi di D-3 Kebidanan (2020-2023) dan Ketua Career Development & Alumni Centre (CDAC) Universitas Sari Mutiara Indonesia (2023 – sekarang). Penulis pernah memenangkan beberapa hibah penelitian, hibah penelitian terbaru tentang Pengaruh *Peer Education* Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan HIV/ AIDS dan juga mendapatkan hibah penelitian dosen pemula Ristek Dikti dengan judul Pengalaman ODHA Dalam Menjalani Terapi Antiretroviral (ARV). Publikasi penulis menghasilkan beberapa karya jurnal terakreditasi sinta, satu jurnal internasional bereputasi, lima buku ber-ISSBN dan penulis memiliki sejumlah hak cipta hasil dari penulisan buku dan pengabdian masyarakat.

SINOPSIS BUKU

Buku ajar "Keperawatan Kesehatan Reproduksi" merupakan referensi komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa keperawatan serta para praktisi kesehatan dalam memahami aspek-aspek penting terkait kesehatan reproduksi. Buku ini menyajikan materi secara terstruktur dan mendalam, meliputi konsep dasar, prinsip utama, serta penerapan klinis yang relevan dalam praktik sehari-hari.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai topik esensial seperti anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, manajemen kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan manusia, serta peran perawat dalam mempromosikan kesehatan dan mencegah masalah reproduksi. Selain itu, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, seperti kesehatan reproduksi remaja, perencanaan keluarga, manajemen infertilitas, serta perawatan kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajarannya yang integratif dan holistik, dengan dilengkapi ilustrasi yang jelas, studi kasus yang nyata, serta evaluasi pembelajaran yang membantu memperkuat pemahaman pembaca. Penyusunan buku ini didasarkan pada literatur terkini dan praktik berbasis bukti, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan praktik keperawatan modern.

Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa, namun juga mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal, responsif, dan berbasis bukti ilmiah. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi di Indonesia serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Buku ajar "Keperawatan Kesehatan Reproduksi" merupakan referensi komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa keperawatan serta para praktisi kesehatan dalam memahami aspek-aspek penting terkait kesehatan reproduksi. Buku ini menyajikan materi secara terstruktur dan mendalam, meliputi konsep dasar, prinsip utama, serta penerapan klinis yang relevan dalam praktik sehari-hari.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai topik esensial seperti anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, manajemen kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan manusia, serta peran perawat dalam mempromosikan kesehatan dan mencegah masalah reproduksi. Selain itu, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, seperti kesehatan reproduksi remaja, perencanaan keluarga, manajemen infertilitas, serta perawatan kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajarannya yang integratif dan holistik, dengan dilengkapi ilustrasi yang jelas, studi kasus yang nyata, serta evaluasi pembelajaran yang membantu memperkuat pemahaman pembaca. Penyusunan buku ini didasarkan pada literatur terkini dan praktik berbasis bukti, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan praktik keperawatan modern.

Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa, namun juga mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal, responsif, dan berbasis bukti ilmiah. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi di Indonesia serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96029-1-4



9

786349

602914